

Thực hư về...

(Tiếp theo trang 18)

- Chất có tác dụng chống dị ứng là acid ganoderic.

- Chất có tác dụng bồi bổ cơ thể là 13 loại acid amin.

- Chất có tác dụng tổng hợp đường và acid amin tương ứng, làm giảm đường huyết.

Độc tính, tác dụng phụ, tương kỵ: Linh chi không độc, không có tác dụng phụ gây hại cho người dùng, không tương kỵ với các dược liệu khác.

Công dụng: Linh chi có tác dụng chống oxy hóa, khử gốc tự do giúp cơ thể chống lão hóa và các bệnh tật do cơ thể lão hóa, kéo dài tuổi thọ.

Nâng cao khả năng sản xuất các kháng thể nội sinh (interferon) chống ung thư, chống các virus gây bệnh như viêm gan siêu vi B, cúm, cảm lạnh và cả HIV.

Chống các stress gây hại như lo âu, buồn chán, thời tiết nóng lạnh thất thường, chuyển mùa, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, người suy nhược thần kinh.

Bảo vệ cơ thể chống ảnh hưởng của các tia xạ: Khi chiếu xạ chữa ung thư, chiếu chụp điện quang, làm việc thường xuyên với máy tính, lò vi sóng v.v...

Chống độc: Giúp cơ thể thải loại nhanh các chất độc vô cơ và hữu cơ do ăn uống, tiếp xúc, hít thở; Các độc tố do ký sinh trùng, vi trùng gây bệnh trong cơ thể, các bệnh suy gan, suy thận v.v...

Giảm cholesterol, chống xơ mỡ mạch máu và các biến chứng như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, nhũn não v.v...

Điều hòa và ổn định huyết áp: Chữa các trường hợp cao huyết áp, huyết áp thấp, huyết áp dao động lúc cao lúc thấp không ổn định.

Chữa chứng nhược cơ, chống dị ứng, phối hợp với thuốc chữa tiểu đường (làm tăng tác dụng), bồi bổ cơ thể cho người suy nhược, tăng trí nhớ.

Cách dùng: Trên thị trường hiện có bán nhiều dạng thuốc như viên

nang, trà túi lọc, dung dịch uống chứa linh chi được phối hợp với vị thuốc khác như nhân sâm, nhưng



Nấm linh chi Trung Quốc (phần mũ nấm) - Ganoderma lucidum (loại 4 cái/kg).

Ảnh: Trần Xuân Thuyết.

hương, vitamin v.v... Những loại thuốc này có tác dụng chính là bồi bổ cơ thể, chống lão hóa, chống suy nhược. Cách dùng theo chỉ dẫn cụ thể của các dược phẩm (Ghi trên bao bì và đơn hướng dẫn sử dụng).

Linh chi nguyên chiếc, linh chi thái lát, linh chi tán bột: Thường dùng độc vị hoặc phối hợp với các vị thuốc khác để chữa bệnh cho từng người theo ý định của thầy thuốc (quân, thần, tá, sứ) dưới dạng thuốc sắc, hoặc hầm với gà, vịt, xương động vật tạo thành món canh thuốc.

Các dạng thuốc trích ly, thuốc sắc, canh thuốc thường bỏ bã, do đó không tận dụng được các hoạt chất của linh chi không tan trong nước.

Do đó cách sử dụng tốt nhất là: Nghiền toàn bộ nấm linh chi (cả mũ nấm và cuống nấm) thành bột mịn.

Khi dùng ăn cả bã và nước (Kể cả món canh thuốc). Khi sắc thuốc có linh chi với nhiều vị khác, cho bột linh chi vào túi riêng, lúc bỏ bã thuốc thì lấy bã linh chi trong túi để ăn rồi uống nước sắc.

Liều dùng: Liều cao dùng trong thời gian ngắn chữa bệnh cấp tính. Ví dụ: Chữa ngộ độc (thức ăn, thuốc, kim loại nặng), dùng liều 120g linh chi chia 3 lần trong ngày.

Chữa viêm tuyến vú: Linh chi 30-50g chia 2 lần trong ngày.

Liều thấp 3g/ngày. Hỗ trợ tăng tác dụng của các loại thuốc như thuốc chữa tiểu đường, chống viêm loét dạ dày. Dùng trong nhiều ngày để nâng cao tuổi thọ, hết liệu trình của thuốc chính hoặc dùng thường xuyên hàng ngày.

Liều trung bình: 6-10g/ngày chia 2 hoặc 3 lần. Với các loại bệnh kể trên, liệu trình trung bình là 2-3 tháng, riêng với ung thư thì dùng thường xuyên hàng ngày cho đến khi khỏi bệnh. ■

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Ban Biên tập báo Sức Khỏe & Đời Sống cuối tuần đã nhận được thư và bài của các bạn:

Trung Tín, Nguyễn Văn Nhân, Trần Thị Bạch Tú, Vũ Anh Phúc, Phan Hữu Khanh, Trần Văn Cương, Nguyễn Đức Hòa, Mai Thị Ánh Tuyết (TPHCM); Dương Minh Huyền, Trần Quang Luyện (Bình Dương); Nguyễn Thanh Hà, Trần Văn Vui, Lê Thanh Bảo (Đồng Nai); Nguyễn Văn Thức (Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hồng Diệp (Tiền Giang); Trác Quới Siêu, Lê Thanh Cường, Trần Hữu Trọng (An Giang); Trần Hồng Sơn, Lê Nguyễn Kim Hương (Kiên Giang); Lê Văn Thắng (Bình Thuận); Phan Thị Thanh (Đắk Lắk); Trần Ngọc Thanh Loan (Khánh Hòa); Chế Tọa (Quảng Ngãi); Đỗ Văn Nhuận, Ngô Thị Ngọc Quế (Thanh Hóa); Vũ Văn Tùng, Lâm Thiên Anh, Phan Thị Minh Như, Hoàng Văn Bường (Hà Nội).

BBT xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các bạn.

Mời bạn đọc truy cập báo SK&ĐS cuối tuần (miễn phí) ở địa chỉ: <http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vn>



Xa nhà CÙNG... TÚI THUỐC

DS. NGUYỄN BÀ HUY CƯỜNG

(ĐH Dược Murdoch - Úc)

Đã xuân đến rồi, du lịch đây đó sẽ là lựa chọn số 1 của rất nhiều người. Cho dù bạn đi gần hay đi xa, quốc nội hay quốc ngoại thì chắc hẳn bạn không bao giờ muốn bệnh tật quấy phá. Nếu được chuẩn bị tốt, chọn... thuốc để đồng hành, được tư vấn kỹ càng bởi bác sĩ và được sĩ trước khi cất cánh thì bạn sẽ giảm được nhiều phiền toái trong khi "phiêu bạt giang hồ". Dưới đây là những nguyên tắc vàng.

1. Rất nhiều loại dược phẩm gây ra hiện tượng "nhạy cảm với ánh sáng" (photosensitivity). Cho dù bạn không bị phóng nắng nhưng nếu tiếp xúc với những dược phẩm loại này sẽ gây ra những phản ứng gây bóng da. Vì vậy, trước khi đi xa đến những vùng có nhiều ánh sáng cần được tham khảo ý kiến của dược sĩ xem những loại thuốc bạn đang sử dụng có những "tiềm năng" gây nhạy cảm với ánh sáng hay không? Nếu cần thiết, các dược sĩ sẽ cung cấp thêm cho bạn những kem

- Khi chải răng nên chia cung răng thành nhiều vùng nhỏ, mỗi vùng từ 2 - 3 răng. Mỗi vùng chải từ 5 - 10 lần giúp làm sạch mảng bám tồn đọng trên răng, kẽ răng, rãnh nướu với lực vừa phải và có tác dụng xoa nắn nướu.

- Cố gắng làm sạch các mảnh vụn thức ăn ở rãnh nướu, kẽ răng, nơi dễ vát thức ăn. Nếu không làm sạch các vùng này sẽ làm cho nướu dễ bị viêm, chảy máu và sâu răng sau này.

- Điều cần lưu ý là chải thật kỹ các răng cối lớn phía sau của hàm trên, hàm dưới nơi dễ bị nhét thức ăn, các răng này rất dễ bị sâu.

- Sau mỗi lần chải răng, nếu có điều kiện nên làm sạch kẽ răng bằng chỉ tơ nha khoa. Chỉ tơ nha khoa giúp lấy sạch các thức ăn vát ở kẽ răng mà bàn chải không thể làm sạch khi chải răng.

- Sau mỗi lần chải răng, nên nhớ làm sạch lưỡi với bàn chải đánh răng hay cây cạo lưỡi sẽ giúp cho miệng có cảm giác sạch và dễ chịu hơn.

- Tập cho trẻ chải răng sớm và đúng cách. Nên dùng chỉ tơ nha khoa, làm sạch kẽ răng.

* Lưu ý:

Sau mỗi lần chải răng, chúng ta thường không biết cách đánh giá xem đã chải sạch tất cả các răng hay chưa? Với những biện pháp đơn giản, chúng ta có thể tự đánh giá mức độ sạch của răng với những biện pháp sau:

- Dùng lưỡi tự kiểm tra mức độ trơn láng và mức độ sạch của các răng.

- Soi gương xem răng có trắng, sạch hay chưa.

- Dùng tấm bóng để kiểm tra các mảng bám trên răng.

- Hay có thể dùng viên nhuộm mảng bám, dung dịch nhuộm mảng bám để kiểm tra việc chải răng có sạch sẽ chưa.

- Nếu cảm nhận răng chưa sạch, như răng vẫn còn mảng bám sẽ bắt màu xanh dương hay màu đỏ hay nhận biết vẫn còn mảng bám thức ăn ở trên răng thì nên chải răng thêm một

lần nữa, điều này là cần thiết giúp cho răng được sạch hơn.

Yếu tố thời gian

- Nếu khi chải răng chỉ làm tốt 3 yếu tố trên thì hiệu quả phòng ngừa bệnh sâu răng và bệnh nha chu chưa đạt kết quả tối ưu, vì còn thiếu một yếu tố nữa là thời gian chải răng.

- Các trường hợp chải răng quá nhanh sẽ không đủ thời gian làm sạch tất cả các răng, mặt răng và không đủ thời gian để chất fluor ngấm vào lớp men răng cho men răng cứng chắc hơn.

- Mỗi lần chải răng, chúng ta nên dành khoảng thời gian từ 3 - 5 phút để làm sạch răng, nướu, lưỡi.

- Điều quan trọng là nên nhớ chải răng sạch sau khi ăn và trước khi đi ngủ.

Khi chải răng, nên hội đủ 4 yếu tố trên. Nếu làm tốt sẽ giúp dự phòng được hầu hết các bệnh răng miệng, nhất là bệnh sâu răng và bệnh nha chu.

Đôi điều về ...

(Tiếp theo trang 16)

sức nguy hiểm là dùng chung cyproheptadin với thuốc corticoid để tăng trọng (1). Một số thuốc khác cũng được dùng kích thích sự thèm ăn: lysin (một acid amin, thường kết hợp với chất khoáng sắt dùng làm thuốc bổ cho trẻ), carnitin (dẫn chất acid amin), dibenzozid (dẫn chất vitamin B₁₂, dùng làm thuốc giúp thức ăn ở người cao tuổi).

Cần lưu ý gì khi sử dụng thuốc bổ?

Sau khi đi qua các thuốc được xem là thuốc bổ, ta nên lưu ý một số điều về việc sử dụng như sau:

Vitamin và chất khoáng: thuốc bổ loại này hoàn toàn không thay thế được thức ăn, thức uống, ta vẫn phải ăn uống đầy đủ chất bên cạnh việc dùng thuốc. Nếu điều kiện tài chính không cho phép, thay vì mua thuốc dùng, nên tập trung tiền mua thức ăn bổ dưỡng, đặc biệt tăng cường trái cây, rau quả (được xem là nguồn vitamin thiên nhiên rất tốt). Không lạm dụng dùng thuốc vitamin quá nhiều, vì có khuyến cáo: nếu bổ sung, chỉ nên dùng

lượng vitamin và chất khoáng trong khoảng 50 - 150% RDA (Recommended Dietary Allowances, liều được khuyến nghị dùng hàng ngày, thí dụ RDA của vitamin C là 60mg/ngày). Riêng vitamin A, D tuyệt đối không được quá liều (thuốc bổ đa sinh tố chứa 5.000 IU vitamin A và 400 IU vitamin D chỉ uống 1 viên/ngày). Đối với phụ nữ có thai, dùng liều quá cao vitamin A có nguy cơ sinh quái thai, còn trẻ con, nếu dùng thừa vitamin A sẽ bị tăng áp lực sọ não rất nguy hiểm.

Thuốc bổ sung vitamin và chất khoáng thường được trình bày dạng viên sủi bọt chứa ion natri, người kiêng muối phải lưu ý vì dùng thuốc nhiều sẽ hấp thu nhiều natri không có lợi (nhất là người đang điều trị bệnh tăng huyết áp, uống thuốc dạng sủi bọt có thể bị tăng vọt huyết áp rất nguy hiểm).

Chất chống oxy hóa và một số thực phẩm chức năng khác: đây chỉ là thuốc phụ trợ, làm giảm nguy cơ bị một số bệnh (ung thư, tim mạch) chứ không phải dùng để điều trị. Nhưng vì lợi nhuận, người ta đã "thối phồng" xem thuốc loại này là "thần dược" trị được bá bệnh, thậm chí cả ung thư để... móc túi người tiêu dùng! Để chống lão hóa, ngừa

ung thư, phải thực hiện nhiều điều trong cuộc sống như: ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, hợp lý, thực hiện các nguyên tắc vệ sinh về thể chất và tinh thần, chống ô nhiễm môi trường... chứ không chỉ sử dụng thuốc không thôi là đủ.

Thuốc kích thích sự thèm ăn: hiện nay, rất nhiều nước không còn dùng cyproheptadin trong chỉ định trị chứng chán ăn. Cần lưu ý chống chỉ định: phụ nữ có thai (do thuốc ảnh hưởng đến thai), phụ nữ cho con bú (thuốc ức chế sự tiết sữa), trẻ dưới 2 tuổi (ảnh hưởng đến hệ thần kinh). Tác dụng phụ được ghi nhận: chóng mặt, ngáy ngạt, chán nản, dễ kích động (người cao tuổi cũng nên tránh dùng).

Thuốc bổ Đông y: theo lý luận Đông y, thuốc bổ có nhiều loại: bổ dương, bổ âm, bổ khí, bổ huyết... Mỗi loại chỉ thích hợp cho một số người bệnh, vì vậy, cần được thầy thuốc Đông y chẩn đoán và cho thuốc là tốt nhất. Đặc biệt, tình hình quản lý thuốc Đông y hiện nay có nhiều điều không như ý, đòi hỏi phải rất thận trọng không nên nghe lời mánh bảo mua thuốc trôi nổi, thuốc pha trộn tãn được nhiều tác dụng phụ như corticoid, dùng tùy tiện có khi có hại chứ không có lợi.

rất đáng tự hào! Món phở, cái bánh chưng, bánh dày, cái bánh ít lá gai, các món ăn "mộc", ăn "nuông" với những gia vị đặc sản tươi mát, bổ dưỡng từ ruộng đồng, rừng núi của Việt Nam được bổ sung bằng các món ăn nấu theo kiểu Tàu, kiểu Pháp... là một nét văn hóa truyền thống nhưng còi mỡ, da dẹt, sáng tạo của ta. Gắn đây, ta lại du nhập thêm nhiều cách ăn uống của Nga, của Nhật, của Hoa Kỳ... Với đã giao lưu buôn bán, du lịch, văn hóa... ẩm thực Việt Nam đi sẽ có những bước phát triển mới.

Về mặt văn hóa, bữa ăn gia đình là rất quan trọng, nó thể hiện bản sắc văn hóa của một dân tộc. Bữa ăn không phải chỉ là bữa ăn, nó cao hơn một bữa ăn, vì nó là tình cảm, là ứng xử, là sự giao lưu giữa vợ chồng con cái ông bà... "Ăn coi nôi, ngồi coi hướng", nhường nhau bát cơm, thức ăn, người mẹ chăm chút chống con, giáo dục trẻ con... ngay trong bữa ăn... tất cả tạo thành một nếp nhà văn hóa của gia đình, một "nếp nhà" được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vai trò của người đàn ông trong bữa ăn cũng cực kỳ quan trọng. Nếu ai đó bỏ đi nhậu nhẹt liên miên, bỏ mặc gia đình của anh ta, thì có thể lo ngại rằng cái nhà ấy tiềm ẩn những nguy cơ...

Trong việc bảo vệ, chấn hưng bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay, vấn đề "bữa ăn", vấn đề "ăn" cần phải được nhìn nhận lại trên xu hướng tôn vinh các giá trị truyền thống, nhưng có học tập chọn lọc thích hợp văn hóa ẩm thực các nước khác, làm sao vừa hiện đại mà không làm mất đi nét truyền thống; làm sao cho có sự giao hòa giữa văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Về phương diện này, ta có thể tham khảo một nước như Hàn Quốc. Đó là một nước, cũng như ta, có truyền thống văn hóa hàng mấy ngàn năm. Một đất nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại nhưng vẫn giữ được truyền thống về mặt ăn uống, họ biết cách tái hiện cái giá trị văn hóa như vậy, tự ta sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng về bản sắc văn hóa, mà hậu quả sẽ là vô cùng lớn về mặt con người.

Bà con gia đình cũng vậy.

SK&DS

Từ đầu năm 2003 đến ngày 10/4/2003, bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận 73 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh viêm não, trong đó có 12 ca được xác định là viêm não cấp đều đã tử vong. Điều này làm hầu hết các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi nguy cơ cao (từ 2-8 tuổi) đều hết sức hoang mang, lo lắng.

Nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về căn bệnh viêm não cấp, phóng viên Báo Sức Khỏe & Đời Sống đã gặp gỡ và trao đổi với BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, BV. Nhi Đồng 1 xung quanh vấn đề này:

PV: Từ tháng 1/2003 đến nay, TPHCM đã rộ lên "Hội chứng viêm não", BS có nhận định gì về tình hình này?

◆ BS. Trương Hữu Khanh: Thực ra, bệnh viêm não không phải là một bệnh mới. Trung bình mỗi năm, BV. Nhi Đồng 1 tiếp nhận vài trăm trường hợp viêm não, gần đây nhất là năm 2002 với 283 trường hợp. Riêng 3 tháng qua bệnh đột ngột tăng rộ lên, đặc biệt trong đó có 12 ca xác định là viêm não cấp đều đã tử vong, khiến mọi người rất lo lắng.

Viêm não cấp là tình trạng viêm cấp tính não bộ. Bệnh có tỷ lệ 15% và để lại di chứng rất nặng (khoảng 35%). Khoảng 40% nguyên nhân cấp là do viêm não Nhật Bản, còn lại chưa rõ nguyên nhân. Theo nhiều tài liệu chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên gia trên thế giới thì cấp do một số loại trùng gây ra với



BS. Trương Hữu Khanh.

nhiều căn nguyên khác nhau như: viêm não Nhật Bản, Enterovirus, Nipah virus, Herpes virus... Siêu vi trùng có thể thâm nhập vào não bộ qua đường máu (do muỗi chích), theo đường tiêu hóa hay theo đường hô hấp và gây nên bệnh viêm não cấp.

Trên 90% bệnh viêm não cấp gặp ở trẻ em và tuổi mắc bệnh thường từ 2-8 tuổi. Bệnh rất hay xảy ra ở vùng nông thôn. Khả năng tử vong do siêu vi trùng xâm nhập bằng đường tiêu hóa cao gấp 2 lần so với đường hô hấp và đường máu. Với 12 ca tử vong do viêm não cấp nói trên, hiện vẫn chưa xác định được loại virus nào gây ra mà còn đang chờ kết quả phân lập của Viện Pasteur TPHCM, nhưng chúng tôi nghĩ nhiều đến nhóm Enterovirus (xâm nhập bằng đường tiêu hóa).

PV: Được biết viêm não cấp có khởi phát bệnh và dẫn đến tử vong rất nhanh. Xin BS cho biết những biểu hiện để nhận biết rõ bệnh?

◆ BS. Trương Hữu Khanh: Trẻ mắc bệnh viêm não cấp thường khởi bệnh đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, ói mửa, lú đờ, bỏ ăn, có thể kèm ho, tiêu chảy, sau 1-2 ngày xuất hiện co giật, hôn mê và dẫn đến tử vong rất nhanh (trong vòng 3 ngày hoặc có trường hợp chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ kể từ khi nhập viện) nếu không được điều trị kịp thời. Qua các ca tử vong,

trạng viêm cấp tử vong cao (10-15%) và để lại di chứng rất nặng (khoảng 35%). Khoảng 40% nguyên nhân cấp là do viêm não Nhật Bản, còn lại chưa rõ nguyên nhân. Theo nhiều tài liệu chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên gia trên thế giới thì cấp do một số loại trùng gây ra với

TRAO ĐỔI VỚI BS. TRƯƠNG HỮU KHANH - TRƯỞNG KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TP.HCM:

Sai lầm của nhiều người cho rằng viêm não cấp là viêm não Nhật Bản...



BS. Trương Hữu Khanh đang thăm bệnh nhi Trần Ngọc Bình, 6 tuổi vừa thoát khỏi tử vong và đang được theo dõi nồng độ oxy trong máu.

chúng tôi nhận thấy trên 90% tử vong trong giai đoạn hôn mê. Đây là giai đoạn quyết định hiệu quả can thiệp của người thầy thuốc.

PV: Theo BS, sự can thiệp của người thầy thuốc trong các ca viêm não cấp đóng vai trò thế nào đến sự sống còn của bệnh nhi?

◆ BS. Trương Hữu Khanh: Tất nhiên, tất cả các BS đều mong muốn giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh viêm não cấp gây ra và hạn chế khả năng mắc di chứng cho các cháu, bởi di chứng của bệnh cũng luôn là nỗi ưu tư đối với người thầy thuốc, cụ thể: yếu liệt chi, động kinh, nặng nhất là không thể tiếp xúc với người nhà dù đã khỏi bệnh hoàn toàn. Hơn nữa, đây là căn bệnh do siêu vi gây ra nên nếu qua cơn nguy kịch thì sau 7 ngày bệnh nhi sẽ tự hồi phục. Do đó, vai trò của người thầy thuốc chủ yếu là bảo đảm kéo dài cuộc sống cho bệnh nhi bằng việc điều trị triệu chứng, điều trị hỗ trợ như hạ sốt, chống co

đốt tỉnh tỉnh và những thói quen hàng ngày như không thích các đồ chơi mà trước đó rất thích, thường hoảng hốt... nhưng phần lớn cha mẹ không lưu ý. Ngoài ra, tôi cũng e ngại một thực tế hiện nay là các bậc cha mẹ còn chủ quan khi con trẻ bị cảm cúm hoặc tiêu chảy, chỉ cho trẻ uống một vài viên thuốc tự mua ở tiệm thuốc tư nhân rồi vội đưa trẻ đến trường học bình thường. Điều này rất không nên vì có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

PV: Có cách nào phòng ngừa căn bệnh này không, thưa BS?

◆ BS. Trương Hữu Khanh: Để phòng ngừa bệnh viêm não cấp nên diệt muỗi, ngủ màn, bảo đảm vệ sinh khi ăn uống, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Tốt nhất nên giữ cho trẻ không bị cảm cúm trong giai đoạn chuyển mùa. Khi trẻ mắc bệnh phải sẵn sàng kỹ: giữ ấm, uống nhiều nước, bảo đảm dinh dưỡng (chỉ ăn các bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, ăn thức ăn dễ tiêu). Khi trẻ bị tiêu chảy phải cách ly với các trẻ khỏe mạnh khác.

PV: Ngoài cách tự bảo đảm vệ sinh trong ăn uống, có thể đưa các cháu đi tiêm phòng để ngừa bệnh?

◆ BS. Trương Hữu Khanh: Hiện nay ở Việt Nam chỉ có thuốc chủng ngừa viêm não Nhật Bản. Trẻ có thể tiêm ngừa viêm não Nhật Bản từ 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng: Nhiều người hiện nay có sai lầm cho viêm não cấp là viêm não Nhật Bản nên cứ nghĩ nếu trẻ đã tiêm ngừa viêm não Nhật Bản rồi là hoàn toàn yên tâm. Điều cần biết là chủng ngừa viêm não Nhật Bản chỉ ngừa được viêm não Nhật Bản chứ không thể ngừa được các loại viêm não khác.

PV: Xin cảm ơn BS về cuộc trao đổi này.

TRẦN QUYÊN (thực hiện)

Tác dụng của khẩu trang và mặt nạ bảo vệ

CÁC LOẠI THIẾT BỊ BẢO VỆ LẠY LAN QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP TRONG Y TẾ

Hoạt động của ngành y tế là một trong những công việc phải tiếp xúc nhiều nhất với các nguy cơ gây bệnh thương trực từ các nguồn khác nhau. Tùy từng môi trường mà nguy cơ lây nhiễm cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn, trong phòng thí nghiệm, ngoài nguy cơ tiếp xúc với hóa chất, nhân viên còn có nguy cơ cao khi tiếp xúc với các loại vi trùng nguy hiểm, có thể gây ra cho họ một tình trạng phơi nhiễm toàn bộ (total exposure). Rối nguồn lây nhiễm trong khu vực phòng bệnh do bệnh nhân phẩy thích các mầm bệnh lây lan, vi sinh vật... Lây lan bệnh nhiễm trùng trong bệnh viện (nosocomial infection) có mô hình hoàn toàn khác với lây lan bên ngoài cộng đồng và thường nặng nề hơn. Do đó tùy từng môi trường làm việc mà người ta có những quy tắc sử dụng các thiết bị bảo vệ khác nhau.

Đối với vấn đề lây nhiễm qua đường không khí, thiết bị bảo vệ trong ngành y tế bao gồm mũ, mặt nạ, găng tay, khẩu trang, áo quần đặc biệt. Riêng về khẩu trang có ba loại: khẩu trang, tấm che mặt và mặt nạ.

Những thiết bị dùng bảo vệ trong các ngành nói chung đều phải được chuẩn hóa. Hiện trên thế giới, thiết bị bảo vệ trong y tế được xác nhận là có tiêu chuẩn cao cấp nếu được sự chuẩn ý của cơ quan NIOSH (National Institute for Occupational Safety & Health, Mỹ).

Những chỉ định sử dụng các loại khẩu trang và mặt nạ:

Khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn

Chỉ định chung trong việc sử dụng khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn:

- Khi có tình trạng văng, bắn, phun các chất dịch có thể.
- Khi ở gần các chất tiết từ khoảng cách 1.5 mét trở xuống.
- Khi làm việc trong không trung

vô trùng, để tránh lây nhiễm cho môi trường.

Nhiều trung tâm kiểm soát bệnh tật và các chuyên gia đã khuyến cáo không sử dụng khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn để ngăn ngừa các bệnh có khả năng lây nhiễm qua đường không khí (như lao, than...). Tuy nhiên điều này vẫn còn đang được bàn cãi.

Vì thế loại khẩu trang này không chỉ được thiết kế để bảo vệ cho nhân viên trong một số trường hợp mà còn để bảo vệ bệnh nhân, cho nên có tên là khẩu trang phẫu thuật. Ngoài việc tránh cho phẫu thuật viên bị nhiễm các chất dịch cơ thể của bệnh nhân, còn nhằm tránh văng bắn dịch tiết mũi họng của nhân viên vào vết mổ hở của bệnh nhân và vào phạm vi phòng mổ.



Khẩu trang phẫu thuật.

Tấm che mặt: Dùng để bảo vệ các niêm mạc mắt, mũi, miệng khỏi bị lây nhiễm trong các thủ thuật hoặc công việc có liên quan đến tình trạng văng, bắn các chất có thể phẩy thích vào không khí và trở thành phần tử treo trong không khí.



Tấm che mặt (face shield).

BS. NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN

(Sydney - Australia)

(Tiếp theo và hết)

Mặt nạ: Là một loại khẩu trang được thiết kế đặc biệt để lọc các phần tử nhỏ lan truyền theo đường không khí. Theo tiêu chuẩn NIOSH (National Institute for Occupational Safety & Health), các loại mặt nạ này phải có khả năng lọc vi khuẩn (BFE, Bacterial Filtration Efficiency) và 95% các phần tử có kích thước nhỏ hơn 0.3 micromet (1milimet = 1.000micromet). Hiện nay có hai loại mặt nạ đạt tiêu chuẩn này, đó là HEPA (High efficiency particulate air filter) và N-95, chúng còn có khả năng không thấm nước.



Mặt nạ (respirator) HEPA và N-95.

HEPA có hiệu quả lọc rất cao, lên đến 99,97%. Còn tại sao gọi là N-95? Theo phân loại mặt nạ dựa trên hiệu quả lọc thì tác dụng lọc được chia làm 3 nhóm: Nhóm không kháng được chất dầu (not resistant to oil) - nhóm N, nhóm kháng chất dầu (oil resis-

tant) - nhóm R và nhóm không thấm dầu (oil proof) - nhóm P. Hiệu quả lọc của nhóm gồm 3 mức: hiệu quả lọc 95%, 99% và 99,97%. Như vậy mặt nạ N-95 là loại mặt nạ không kháng được chất dầu và có hiệu quả lọc 95% các phần tử quy định.

VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Trên đây là những đặc điểm kỹ thuật của các loại thiết bị bảo vệ đường hô hấp sử dụng trong y tế. Chúng đòi hỏi không chỉ đạt tiêu chuẩn như mong muốn mà còn phải được chứng minh là có hiệu quả trong các điều kiện nào đó. Vì vậy những chỉ định sử dụng cần phải phù hợp với thiết kế để đạt hiệu quả tối ưu. Nếu sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy cách có khi còn phản tác dụng.

Con đường phát triển từ chiếc khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn đến các mặt nạ cao cấp

Tác dụng của khẩu trang trong việc ngăn ngừa sự thâm nhập một số chất vào đường mũi họng là điều không có gì bàn cãi. Đối với loại vi khuẩn có tính chất lây lan mạnh và phát tán trong không khí, người ta sợ nhất là vi khuẩn lao, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện và với những bệnh nhân kháng thuốc. Vì vậy con đường phát triển của khẩu trang cũng gắn liền với cuộc chiến đấu chống lại bệnh lao trên thế giới.

Nói đến bệnh lao, ít nhiều ai cũng biết đến tám nguy hiểm của nó. Nhà bác học Robert Koch (Đức) là người đầu tiên tìm ra tác nhân này - nên vi trùng gây bệnh lao còn được gọi là vi trùng Koch. Nhờ phát hiện này của ông, sau đó y học đã có thể không chế được bệnh lao một cách hiệu quả. Thế nhưng vào những thập kỷ 80 của thế kỷ XX thì bệnh lao lại bùng phát khắp nơi, làm giới y học phải tái thẩm định các chương trình phòng chống lao. Vào năm 1990, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh truyền

nhễm (CDC), Mỹ đã đưa ra hướng dẫn để phòng chống bệnh lao phổi với khuyến cáo là phải sử dụng "mặt nạ đặc hiệu" (particulate respirator) thay thế cho cụm từ "khẩu trang phẫu thuật" (surgical mask) đang được sử dụng rộng rãi trong giới nhân viên y tế để ngăn ngừa phơi nhiễm (exposure) với lao phổi.

Điều hiển nhiên là các loại mặt nạ mới này có hiệu quả tốt hơn nhiều so với khẩu trang phẫu thuật. Nhưng liệu nó có tốt hơn trong việc phòng chống bệnh lao (trên phương diện kiểm soát tỷ lệ mắc lao) so với khẩu trang phẫu thuật hay không lại là chuyện khác (Ngoại trừ việc sử dụng khẩu trang khi cần di chuyển bệnh nhân bị lao phổi để tránh phẩy thích nguồn bệnh ra ngoài là hoàn toàn có cơ sở).

Tuy nhiên, một số chương trình chống lao lúc đó cho thấy có thể đạt hiệu quả (giảm tỷ lệ mắc) mà chẳng cần sử dụng đến loại "mặt nạ đặc hiệu" này. Một ý kiến biện minh cho việc thay đổi trong khuyến cáo này là: "Các khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn có thể không hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự hít phải các nhân dịch tiết rơi vãi (droplet nuclei)". Trong khi đó việc kiểm chứng tính ưu việt

của "mặt nạ đặc hiệu" lại rất đắt đỏ, mà lợi ích bảo vệ nhân viên y tế thì vẫn chưa được xác định.

Trong một nghiên cứu của Laura Gammaitoni và Maria Clara Nucci, các tác giả đã sử dụng mô hình toán xác định để đo lường độ nhiễm lây qua đường không khí, tóm tắt hiệu quả của các thiết bị bảo vệ đường thở như sau: Nếu sử dụng mặt nạ lọc khí loại HEPA (High efficiency particulate air filter) hoặc kết hợp với UVGI (ultra-violet germicidal irradiation), có khả năng bảo vệ sự lây truyền lao thể hiện khi tỷ lệ nhiễm trùng thấp, đặc biệt với mức độ phơi nhiễm ngắn. Khi tỷ lệ nhiễm trùng tăng lên, dù có dùng mọi biện pháp khử trùng, kể cả dùng mặt nạ và tăng thông khí cũng không thể nào làm giảm được nguy cơ lây lan. Ngoài ra nghiên cứu còn kết luận: "Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát bằng quản lý (nghĩa là nhân dạng bệnh, cách ly bệnh nhân tốt) là biện pháp hiệu quả nhất vì chỉ có vậy mới làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng".

Như vậy đối với loại bệnh nhiễm trùng có nguy cơ lây lan qua đường không khí đáng sợ nhất là lao thì các nghiên cứu cho thấy: Chưa có cơ sở nào chứng minh khẩu trang loại tốt nhất (mặt nạ N-95, HEPA) là hiệu quả hơn loại khẩu trang phẫu thuật để bảo vệ nhân viên y tế giảm nguy cơ nhiễm lao trong bệnh viện. Hơn nữa trong các biện pháp áp dụng, chỉ có biện pháp nhân dạng bệnh sớm, cách ly bệnh nhân tốt là phương thức hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc lao.

Điều kỳ diệu

Chỉ biết rằng

Những bông hoa luôn nở vào mùa xuân

Những dòng sông chờ phù sa miệt mài

Dòng sữa tốt lành của đàn bò cái

Sự cực nhọc của người lương thiện

Là hiện hữu nhiệm mầu.

Và thật dễ dàng cho ta mỉm cười

Khi cuộc đời trôi chảy như bãi sa

Nhưng kỳ diệu hơn cả

Là người biết bình thản an nhiên

Dù đời đang đi vào vô vọng...



Đã tới lúc bạn nên đi làm xét nghiệm Homocysteine

BS. NGUYỄN LÂN ĐÌNH
(Chuyên viên Dinh dưỡng)

Ở Mỹ hiện nay, người ta rất chú ý đến chỉ số Homocysteine trong máu. Đã có thông tin cho biết vào tháng 4/2003, những kết quả nghiên cứu mới nhất về vấn đề này sẽ được công bố tại Kỳ họp thường niên của Viện Hàn lâm Thần kinh học Mỹ ở Hawaii.

Có phải Homocysteine cao để dẫn tới bệnh mất trí Alzheimer?

Các nhà nghiên cứu ở Anh đã đưa ra bằng chứng khá thuyết phục là Homocysteine cao trong máu có thể là một nguyên nhân dẫn tới bệnh Alzheimer - mà chỉ riêng ở Anh hiện đã có tới 1/2 triệu người mắc phải.

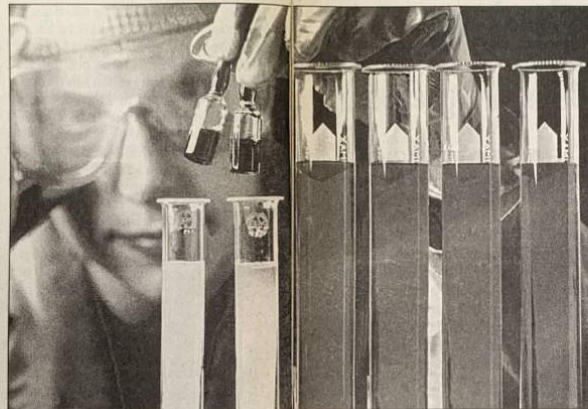
Trong máu, tỷ lệ Homocysteine càng cao sẽ càng dễ liên quan tới sự xuất hiện của chứng mất trí hay tâm thần phân liệt (dementia) và mất trí nhớ (loss of memory). Trong công trình nghiên cứu của các tác giả Anh, những hình ảnh "quét não cắt lớp siêu âm cộng hưởng từ" (MR scans) được thực hiện trên hơn 1.000 đối tượng có bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh tuổi từ 60 đến 70. Họ nhận thấy những người nào đã có các mức nồng độ Homocysteine cao trong máu 6 hay 8 năm trước, phần nhiều có khối não nhỏ hơn và kết quả trắc nghiệm kém

năm gần đây, người ta đã chú ý tới mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ Homocysteine và hoạt động não bộ. Homocysteine rõ ràng là gây tác hại đối với cả động mạch, tĩnh mạch và tổ ra độc hại ngay cả chính với não.

Homocysteine cao có làm suy tim sung huyết?

Trong một bài báo đề cập đến Homocysteine đăng trong tờ báo của Hội Y khoa Mỹ (Journal of the AMA, số ra ngày 12/3/2003), các tác giả cho thấy những hàm lượng Homocysteine cao trong huyết tương rõ ràng là một yếu tố nguy cơ cao đối với chứng suy tim sung huyết (congestive heart failure), đặc biệt là ở phụ nữ. Khoảng 25.000 đối tượng nam và nữ tham gia vào công trình nghiên cứu Framingham về tim hơn 20 năm trước đã được theo dõi "tiền cứu" (prospectively followed) trong 6-10 năm. Người ta khám phá ra rằng những người có hàm lượng Homocysteine cao nhất trong

máu có nguy cơ phát sinh suy tim sung huyết lớn hơn khoảng 4 lần so với nhóm có hàm lượng thấp nhất. Xin lưu ý là trước đó họ không hề có tiền sử bị những cơn đau tim và hiện tượng nồng độ Homocysteine tăng tỏ ra có liên quan với sự phát sinh tình trạng



suy tim sung huyết mà không tùy thuộc vào bất cứ yếu tố nào khác.

Nhiều nghiên cứu khác trong y văn đã cho thấy có sự liên quan rõ rệt giữa hàm lượng Homocysteine trong máu và nguy cơ phát sinh những cơn đau tim, đột quỵ, thậm chí cả chứng viêm tĩnh mạch (phlebitis). Trong một bài báo đăng trên tờ British Medical Journal, người ta đã tính nếu uống mỗi ngày 800mcg acid folic sẽ làm hạ mức Homocysteine trong máu đủ để giảm nguy cơ 16% đối với cơn đau tim, 24% đối với đột quỵ (stroke) và 25% đối với viêm tĩnh mạch

huyết khối (thrombophlebitis).

Làm thế nào để hạ mức Homocysteine?

Nên đi đo Homocysteine trong máu và theo dõi chỉ số này thường xuyên. Xét nghiệm này không chỉ mang tính cách thử nghiệm mà thực sự là một chỉ số hữu ích để kịp thời đối phó, phòng tránh được những bệnh tim và não!

Vấn đề làm hạ Homocysteine trong máu khá dễ dàng, chỉ việc uống đủ liều 3 sinh tố acid folic, B6 và B12. Một số công trình nghiên cứu thấy phải uống tới 10mg (tức 10.000mcg) acid folic/ngày mới làm hạ được Homocysteine. Những dưỡng chất khác có thể phụ giúp vào mục tiêu này như: Trimethylglycine (betaine), N-acetyl cysteine (NAC), kẽm (= zinc, dưới dạng kháng oxy hóa tốt nhất là L-OptiZinc), inositol và chất SAME. Viện Khoa học Dưỡng phẩm (Nutraceutical Sciences Institute (NSI)) gần đây đã bảo chế một sản phẩm với mục đích làm hạ những mức Homocysteine cao mang tên Công thức Homocysteine (Homocysteine Formula HF).

Mỗi viên nang HF đem lại 100mg vitamin B6, 2mg (= 2.000mcg) acid folic, 2mg (= 2.000 mcg) B12 (methylcobalamin), 300mg NAC, kẽm và inositol. Đối với những ca homocysteine cao nghiêm trọng thì cần nhiều acid folic hơn 4-10mg/ngày, 2mg B12 hoặc hơn nữa và tới 200mg B6.

Thêm vào đó cũng nên uống thêm tới 6-8g trimethylglycine, 2mg N-acetyl cysteine (NAC) mỗi ngày.

Các chuẩn mức homocysteine

Các phòng xét nghiệm thường đưa ra những số chuẩn mức Homocysteine bình thường lên tới 15mcmol/L. Mục tiêu dài hạn của bạn là nên đạt mức tối ưu dưới 7,2mcmol/L, đạt tới mức này càng sớm càng có lợi. Đừng đợi tới khi bị cơn đau tim, đột quỵ hay có dấu hiệu mất trí nhớ đầu tiên mới đi thử Homocysteine!

CÙNG NGẮM NGHĨ

□ Xưa nay, khi nói đến tiêu chí của một người quản lý, nhất là quản lý ở cấp vĩ mô, thì một trong những tiêu chí được coi là quan trọng bậc nhất là tài "dùng người" của người đó. Nhiều người quản lý thành đạt, khi được hỏi bí quyết thành công của mình đều trả lời: "Bí quyết thành công của tôi là ở chỗ biết dùng người giỏi hơn mình" (GS. Nguyễn Cảnh Toàn - Sử dụng nhân tài - báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn VN 1/3/2003).

□ Kinh tế tri thức là một thử thách lớn lao về quyết tâm và năng lực. Muốn phát triển kinh tế tri thức có hiệu quả thì phải có một môi trường xã hội phù hợp, một cơ địa cho sự tồn tại và trưởng thành.

Muốn xây dựng và phát triển kinh tế tri thức thì cũng đồng nghĩa với sự hiện diện một xã hội tri thức, vì nó là tiền đề, là môi trường vận động và phát triển tri thức. Kinh tế tri thức sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của xã hội. (PGS. TS. Trần Cao Sơn - báo Lao động 1/4/2003)

□ Dạy và học xét cho cùng vẫn mang tính nghệ thuật nhiều hơn, cái hay, cái tốt là do ở tính truyền cảm hơn là ở lý lẽ; và chẳng lý lẽ cũng phải nhuần thấm đến mức độ của cảm thụ thì mới mong đạt được hiệu quả cao (GS. Phạm Đình Diệu - báo Giáo dục & Thời đại).

□ Chẳng cần thiết đưa ra câu trả lời đối với cuộc chiến "trường chơi đá" ngày nay giữa Iraq và Mỹ. Máu sẽ nhuộm đỏ con đường dẫn đến chiếc ngai vàng và vòng nguyệt quế sẽ được đội lên chiếc nón cao bồi. Và rồi sẽ còn tiếp tục những hành động cường tinh, đoạt lý, "cả vũ lấp miệng em" để nhai chìm thiên hạ trong khiếp nhược. Và rồi sẽ có một ít vỏ vè và vài mẩu bánh vụn cũng rất nhiều rắn đe để đối lấy sự phục tùng.

Chiến thắng đó ư? Không! Lịch sử chứng minh đó chỉ là sự vũ dụng. Chiến thắng thật sự chỉ đến bằng việc chinh phục trái tim và khối óc (Công Minh - báo Tuổi trẻ - 20/3/2003).

□ Lòng đôn hậu của người dân Iraq - chính là điều làm tôi ám lòng nhất và cũng làm tôi suy nghĩ nhiều nhất. Trước khi đến Iraq, tôi chỉ nghĩ đến chuyện phản chiến và làm thế nào để cứu được nhiều người dân, nhưng đến đây tôi nhìn thấy nhiều hơn và những gì nhìn thấy làm tôi suy nghĩ rộng hơn, khiến tôi càng tin yêu người Iraq (Rony Mc Ewan - Công dân Scotland).

30

tỷ đồng là số tiền Thủ tướng Chính phủ đã ký duyệt nhằm phục vụ trực tiếp công tác điều trị, cấp cứu và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp ở nước ta

DINH DƯỠNG

Chế độ ăn là yếu tố hết sức cần thiết trong điều trị bệnh tiểu đường (TD), song trước nay có nhiều quan niệm sai lầm xung quanh việc khuyến cáo về dinh dưỡng trong công tác chữa bệnh. Bệnh nhân thường ăn uống

đường - vitamin - muối khoáng - nước với khối lượng hợp lý.

2. Không làm tăng đường máu nhiều sau khi ăn.

3. Không làm hạ đường máu lúc xa bữa ăn.

4. Duy trì được hoạt động thể lực bình thường hàng ngày.

5. Duy trì trọng lượng ở mức cân nặng lý tưởng hoặc giảm cân đến mức hợp lý.

6. Không làm tăng các yếu tố nguy cơ như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, suy thận...

tổng số calo hàng ngày. Theo quan niệm trước đây, lượng bột - đường cần phải hạn chế, song qua những quan sát về dịch tễ trên cộng đồng sử dụng nhiều chất bột - đường (người sống ở nông thôn, người có mức sống eo hẹp, thô dân...) không thấy có sự gia tăng số người mắc TD mà trái lại khi cộng đồng này có điều kiện hơn về dinh dưỡng (di cư, phát triển kinh tế), tiêu thụ nhiều chất béo và chất đạm hơn lại thường kéo theo sự bùng nổ về số người mắc TD. Mặt khác, nghiên

Khuyến cáo mới về dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường

["Bình thường hóa" về chế độ ăn cho người tiểu đường không béo phì]

theo sự mạch bảo là chủ yếu. Điều đó có căn nguyên từ sự hiểu biết hạn chế về nguyên nhân gây bệnh TD, về các phương thức điều trị... Với tiến bộ của khoa học, của các loại thuốc điều trị TD mới, ngày nay người ta có xu hướng tự do hóa: thành phần chất bột - đường trên cơ sở thỏa mãn cùng lúc nhiều yếu tố như: cân bằng đường máu; Giảm thiểu các yếu tố nguy cơ lên hệ tim mạch, lên chức năng thần; Tôn trọng sở thích cũng như thói quen của bệnh nhân và cả gia đình bệnh nhân với phương châm: "Sức khỏe không chỉ là tình trạng có bệnh hay không mà còn là tình trạng thoải mái cả về thể chất cũng như tinh thần".

Do vậy chế độ ăn cần được điều chỉnh thích ứng cho từng bệnh nhân riêng biệt, thỏa mãn đầy đủ một số yêu cầu cơ bản sau:

1. Đủ chất đạm - béo - bột -



7. Phù hợp với tập quán ăn uống của địa dư, dân tộc, của từng bệnh nhân và gia đình.

8. Đơn giản và không quá đắt tiền.

9. Không nên thay đổi quá nhanh và nhiều về cơ cấu cũng như khối lượng của các bữa ăn.

THÀNH PHẦN CHẤT BỐT - ĐƯỜNG (CARBOHYDRATE)

Là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, chiếm từ 60-70%

BS. NGUYỄN HUY CƯỜNG

(Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, BV. Bạch Mai)

Tỷ lệ chất béo trong bữa ăn của người Việt Nam *cao không cao* (chỉ chiếm từ 12-20% tổng số calo tiêu thụ hàng ngày - theo điều tra dinh dưỡng năm 2000 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia), khuyến cáo về tỷ lệ chất béo trước đây vào khoảng 25-30% áp dụng cho người Việt Nam là không thực tế vì:

- Không hợp khẩu vị của đa số người Việt Nam, trong đó có người bị TD.

- Tạo điều kiện cho tăng mỡ máu ở người bị TD vốn chiếm tới 40%.

- Tạo điều kiện cho béo phì phát triển thêm (có khoảng trên 40% số người bị TD ở vào tình trạng thừa cân và béo phì với BMI $\geq 23\text{kg/m}^2$).

Do vậy tỷ lệ chất béo trong khẩu phần bệnh nhân TD nên trong phạm vi người bình thường (từ 15-20%) là hợp lý. Tuy nhiên tỷ lệ chính xác là bao nhiêu còn phụ thuộc vào các đặc điểm cá nhân như: Thói quen ăn uống của bệnh nhân và gia đình, tình trạng béo phì, tăng mỡ máu, huyết áp, lượng đường máu... Với người có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, lượng chất béo nên hạn

Uớc lượng lượng đường trong

một số thức ăn:

- Sữa tươi hoặc sau khi đã pha có 5% đường.

- Rau xanh có từ 2-10%.

- Quả tươi có 5-15%.

- Bánh mì có 50-55%.

- Gạo có 75-80%; Cơm có từ 40-50%; Miến có 83%.

- Khoai có 20%.

Với một số người, chế độ ăn giàu chất bột - đường có thể làm tăng triglyceride máu, vì vậy bác sĩ và nhà dinh dưỡng cần kiểm tra về các vấn đề:

- Đường máu đã thực sự ổn định chưa, có tăng đường máu sau ăn không?

- Bệnh nhân có uống nhiều rượu, bia?

- Tình trạng béo phì có được cải thiện? Có tập thể dục không?

Sau khi đã loại bỏ các yếu tố trên (tăng triglyceride thực sự do chế độ ăn giàu chất bột - đường) cần giảm lượng tinh bột, tăng chất béo không bão hòa (dầu thực vật), tăng chất xơ.

THÀNH PHẦN CHẤT BÉO (LIPIDE)

Tỷ lệ chất béo trong bữa ăn của người Việt Nam *cao không cao* (chỉ chiếm từ 12-20% tổng số calo tiêu thụ hàng ngày - theo điều tra dinh dưỡng năm 2000 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia), khuyến cáo về tỷ lệ chất béo trước đây vào khoảng 25-30% áp dụng cho người Việt Nam là không thực tế vì:

- Không hợp khẩu vị của đa số người Việt Nam, trong đó có người bị TD.

- Tạo điều kiện cho tăng mỡ máu ở người bị TD vốn chiếm tới 40%.

- Tạo điều kiện cho béo phì phát triển thêm (có khoảng trên 40% số người bị TD ở vào tình trạng thừa cân và béo phì với BMI $\geq 23\text{kg/m}^2$).

Do vậy tỷ lệ chất béo trong khẩu phần bệnh nhân TD nên trong phạm vi người bình thường (từ 15-20%) là hợp lý. Tuy nhiên tỷ lệ chính xác là bao nhiêu còn phụ thuộc vào các đặc điểm cá nhân như: Thói quen ăn uống của bệnh nhân và gia đình, tình trạng béo phì, tăng mỡ máu, huyết áp, lượng đường máu... Với người có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, lượng chất béo nên hạn

chế. Với người gầy và không có yếu tố nguy cơ tim mạch: lượng chất béo có thể tăng lên trên cơ sở bệnh nhân dung nạp được chế độ ăn đó. Đối với người TD type 2: Việc điều chỉnh các yếu tố nguy cơ tim mạch (trong đó có rối loạn mỡ máu) còn có lợi hơn so với điều chỉnh đường máu.

Nguồn gốc chất béo: Vì đa số người TD ở vào độ tuổi >60, tỷ lệ chất béo có nguồn gốc động vật/ thực vật nên là 50/50. Việc thay toàn bộ chất béo động vật bằng chất béo có nguồn gốc thực vật là không cần thiết (vì làm

calo). Khi suy thận cần phải giảm lượng đạm tiêu thụ 0,6g/kg/ngày, nhưng không được <0,5g/kg/ngày vì dễ dẫn đến suy dinh dưỡng.

CÁC YẾU TỐ VI LƯỢNG VÀ VITAMIN

Việc sử dụng liều cao các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta caroten, selenium không được chứng minh có tác dụng bảo vệ bệnh tim mạch, ung thư và TD trong các thử nghiệm lớn có đối chứng với giả dược, thậm chí còn gây tác dụng phụ bất lợi.



Bệnh nhân tiểu đường nên chú ý kiểm soát đường huyết thường xuyên.

giảm vitamin A, D tan trong mỡ động vật; Khó chế biến thức ăn...)

Lượng cholesterol ăn vào hàng ngày < 300mg. Với các trường hợp có tăng cholesterol và nguy cơ tim mạch lượng cholesterol ăn vào < 200mg/ngày.

THÀNH PHẦN CHẤT ĐẠM (PROTIDE)

Tỷ lệ chất đạm chiếm từ 10-20% tổng số calo hàng ngày tương ứng khoảng 0,8-1,2g/kg cân nặng (100g thịt nạc có khoảng 18g đạm, 100g gạo có khoảng 7g đạm). Với chế độ ăn giàu đạm hơn có thể ảnh hưởng đến *tổn thương thận* do TD (khoảng 30% người TD có biến chứng thận). Mặt khác ăn nhiều đạm về lâu dài sẽ gây chán ăn và chi phí đắt tiền, tuy nhiên chế độ ăn giàu đạm có thể được áp dụng trong thời gian ngắn khi đường máu còn cao và khi áp dụng chế độ ăn giảm cân (giảm

Chỉ nên sử dụng nhiều loại *vitamin liều thấp* trong trường hợp cần thiết (suy nhược, kém hấp thu...) khi xác định có thể thiếu vitamin.

Tuy nhiên với phụ nữ có thai nên cung cấp thêm acid folic để phòng tránh dị dạng ống thần kinh và một số dị dạng khác; Canxi (1.000mg/ngày) để đề phòng các bệnh về xương.

RƯỢU

Rượu uống với lượng vừa phải (5-15g/ngày) sẽ làm giảm nguy cơ tim mạch, có thể do rượu làm tăng lượng HDL - cholesterol, nhưng nếu lạm dụng hơn mức nói trên lại có tác động xấu đến sức khỏe.

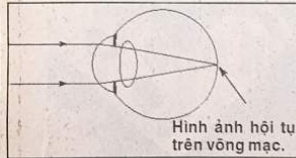
Với phụ nữ, có thể dùng 340ml (12oz) bia, rượu vang 140ml (5oz), rượu mạnh 42ml (1,5oz). Đàn ông có thể dùng gấp đôi lượng trên.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG

(Xem tiếp kỳ sau)

1. Cấu tạo của mắt
Mắt thường được ví như một máy ảnh:

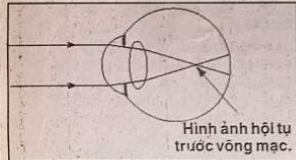
- Giác mạc và thủy tinh thể được ví như vật kính của máy ảnh.
- Mống mắt được coi như Diaphragm của máy ảnh.
- Nhân cầu giống như buồng tối.
- Vong mạc giống như phim.
- Mắt bình thường là mắt có cấu tạo hài hòa giữa trục trước sau của nhân cầu và công suất quang học của hệ giác mạc thủy tinh thể sao cho ánh sáng từ vật rơi đúng trên vong mạc. Giống như khi ta hiệu chỉnh đúng tiêu cự của máy ảnh sẽ cho ra hình ảnh đẹp và rõ nét.



2. Thế nào là tật khúc xạ

Tật khúc xạ của mắt cũng giống như sự hiệu chỉnh sai của thấu kính máy ảnh sẽ cho ra hình ảnh mờ, không rõ nét và đôi khi bị bóng đôi. Các loại tật khúc xạ thường gặp là:

a. Cận thị: Cận thị thường do trục trước sau của nhân cầu quá dài trong khi công suất của các thấu kính (hệ giác mạc thủy tinh thể) là bình thường, hoặc công suất của các thấu kính quá cao trong khi độ dài trục trước sau là bình thường. Do đó với vật ở vô cực ta sẽ nhìn mờ vì ảnh rơi trước vong mạc.



Nguyên nhân cận thị hiện vẫn chưa được biết rõ, nhưng người ta cho rằng có 2 yếu tố thúc đẩy, đó là di truyền và yếu tố môi trường.

Đặc điểm của cận thị là nhìn xa không rõ nhưng nhìn gần rõ. Tùy

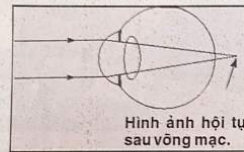
NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ

tật khúc xạ

theo độ cận thị mà người ta phải đặt sách ở xa hoặc thất gần mắt mới đọc được.

Cận thị thường xuất hiện ở lứa tuổi đi học hay còn gọi là cận thị học đường. Trẻ thường phải đặt sách sát mắt để đọc, không nhìn thấy bảng hoặc phải chạy đến gần TV. Trẻ thường hay nheo mắt hoặc than nhức đầu, mỏi mắt.

b. Viễn thị: Ngược với cận thị, ở người viễn thị mắt có trục trước sau quá ngắn hoặc công suất hội tụ của mắt không đủ để hội tụ ánh sáng từ vật ở vô cực sẽ rơi ra sau



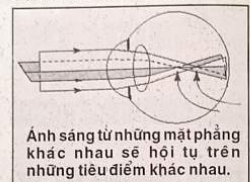
vong mạc.

Viễn thị thường xuất hiện ở trẻ em khi còn bé, có thể giảm hoặc mất hẳn do quá trình chỉnh thị hóa của mắt (nhân cầu dài ra).

Nếu viễn thị vẫn tồn tại, mắt chúng ta sẽ bù trừ bằng hiện tượng điều tiết. Hiện tượng điều tiết được giải thích như sau: do thủy tinh thể của mắt có tính đàn hồi nên thủy tinh thể có khả năng co giãn, thay đổi hình dạng, nhờ có hiện tượng này mà thủy tinh thể có thể thay đổi độ cong, gia tăng công suất hội tụ, nên kéo ảnh về đúng trên vong mạc. Tùy theo mức độ viễn thị so với khả năng điều tiết của mắt mà mắt có thể nhìn xa và gần đều rõ hoặc nhìn xa rõ, nhìn gần mờ hoặc cả nhìn xa và gần đều mờ. Viễn thị nhẹ ở người còn trẻ hoặc trẻ em thường không có triệu chứng. Ở người cao tuổi do sức điều tiết giảm sút hoặc người trẻ có viễn thị trung bình đến nặng mới bị ảnh

hường, trong trường hợp này triệu chứng sẽ là mỏi mắt, nhức mắt hoặc nhức đầu, nhìn gần mờ nếu phải tập trung làm các công việc đòi hỏi nhìn gần kéo dài.

c. Loạn thị: Xảy ra khi giác mạc có độ cong không đều nhau ở các hướng kinh tuyến (có một kinh tuyến cong nhất và một ít cong



nhất, thường là 2 kinh tuyến này vuông góc nhau).

Giác mạc mắt không loạn thị được ví như một nửa trái banh bóng đá cắt ra.

Giác mạc mắt loạn thị được ví như một nửa trái banh bóng bầu dục cắt ra.

Loạn thị thường do bẩm sinh và thường chỉ được phát hiện khi trẻ bắt đầu đi học hoặc loạn thị nặng có triệu chứng chức năng.

Loạn thị thường đi kèm với tật cận thị hoặc viễn thị.

Loạn thị thường được cho là do di truyền, nhưng cũng có những nguyên nhân khác như do chấn thương, sẹo giác mạc, do phẫu thuật tác động lên các vùng có liên quan hoặc do giác mạc hình chóp.

Triệu chứng của loạn thị là:

- Đối với loạn thị nhẹ, bệnh nhân thường mỏi mắt, nhức đầu hoặc nhìn mờ ở một khoảng cách nào đó.

- Loạn thị nặng thường gây hiện tượng nhìn hình ảnh biến dạng và nhìn mờ ở mọi khoảng cách.

d. Lão thị: Lão thị chỉ là một quá trình biến đổi sinh lý của mắt.

BS. LÊ THỊ THANH XUYỀN

(BV. Mắt - TPHCM)

Như đã nêu trên, thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ đặc biệt vì nó có khả năng thay đổi được độ cong để nhìn rõ một vật ở gần mắt nhờ tính đàn hồi của mình (người ta gọi đây là hiện tượng điều tiết). Nhưng sự đàn hồi này của thủy tinh thể ngày càng kém đi, ở vào lứa tuổi trên 40 thì sự suy giảm sức điều tiết của thủy tinh thể sẽ gây trở ngại cho việc đọc sách và làm các công việc gần. Do đó ở lứa tuổi này, muốn đọc sách người ta thường phải đưa sách ra xa mắt. Để điều chỉnh lão thị, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân đeo kính hội tụ để bù đắp cho sức điều tiết mất đi. Chính việc cho đeo kính hội tụ này đã làm nhiều người lẫn lộn giữa lão thị và viễn thị vì cả hai đều đeo kính hội tụ. Cần phân biệt hai loại này vì viễn thị là một tật khúc xạ có thể xuất hiện ngay cả ở trẻ em, còn lão thị chỉ là một biến đổi sinh lý của mắt và chỉ xuất hiện ở lứa tuổi ngoài 40.

Lão thị thường xuất hiện muộn hơn ở người cận thị và sớm hơn ở người viễn thị.

Các triệu chứng thường gặp của lão thị: Nhìn mờ các vật ở gần, đọc những chữ nhỏ khó khăn, mỏi mắt khi đọc ở nơi có ánh sáng yếu hoặc vào lúc cuối ngày, mỏi mắt nhức đầu khi làm công việc nhìn gần kéo dài, phải đưa sách ra xa mới đọc được.

e. Tật không có thủy tinh thể và kính cường: Như chúng ta đã biết, theo thời gian, do những thay đổi về biến dưỡng hoặc do bệnh lý mà thủy tinh thể mất đi tính trong suốt làm cho người bệnh nhìn mờ, do đó bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật để lấy đi thủy tinh thể bị đục. Vì một lý do nào đó nếu không thể đặt vào mắt một thủy tinh thể

nhân tạo (IOL) thì lúc đó mắt sẽ trở thành mắt không có thủy tinh thể, gần giống như một mắt bị viễn thị nặng (mắt đã bị mất đi một thấu kính hội tụ). Lúc đó muốn nhìn rõ một vật ở xa, người ta phải đeo một thấu kính hội tụ có công suất trung bình từ +9.00D đến +14.00D.

3. Cách điều chỉnh tật khúc xạ

a. Cận thị: Dùng thấu kính phân kỳ (là thấu kính có rìa dày hơn phần tâm) thích hợp để đưa ánh sáng từ trước vong mạc về đúng trên vong mạc.

b. Viễn thị: Người ta dùng thấu kính hội tụ (là thấu kính có rìa mỏng hơn phần tâm) thích hợp để đưa ánh sáng từ sau vong mạc về đúng trên vong mạc.

c. Loạn thị: Người ta dùng thấu kính trụ, là thấu kính có tác dụng quang học ở một hướng nhất định để chỉnh lại sự bất đồng về công suất giữa các kinh tuyến gây ra bởi sự cong không đều giữa các kinh tuyến trên giác mạc.

d. Lão thị: Trên nguyên tắc, người lão thị sẽ được đeo một thấu kính hội tụ để bù đắp vào sức điều tiết mất đi khi nhìn gần. Nhưng tùy thuộc vào loại tật khúc xạ mà người đó có khi còn trẻ, tùy thuộc vào nhu cầu công việc cũng như cuộc sống mà bác sĩ sẽ cho bệnh nhân đeo kính đọc sách, đeo hai kính, kính hai trong hoặc kính có

công suất tăng dần (kính progresive).

4. Tật khúc xạ có thể chữa khỏi được không?

Gọi là tật khúc xạ nhằm để diễn tả tình trạng cấu tạo không hoàn toàn của mắt chứ không phải là một tình trạng bệnh lý, do đó người ta lại gọi là tật khúc xạ chứ không phải bệnh khúc xạ và thường nói là điều chỉnh tật khúc xạ chứ không gọi là điều trị tật khúc xạ.

Tật khúc xạ được điều chỉnh bằng cách đeo kính gọng hoặc kính tiếp xúc (contact lens). Tuy nhiên việc đeo kính chỉ giúp thấy rõ và thoải mái chứ không làm cho tật khúc xạ biến mất, khi gỡ kính ra thì vẫn thấy mờ.

Người ta thường nói đeo "kính thuốc", nhưng thực ra đó là đeo kính gọng như trên và trong kính cũng không tiết ra loại thuốc nào để làm giảm tật khúc xạ.

Hiện nay có một phương pháp điều trị tật khúc xạ (làm giảm hoặc làm mất tật khúc xạ), đó là mổ bằng Laser Excimer. Phương pháp này được áp dụng cho tật khúc xạ trung bình trở lên và ở người ≥ 18 tuổi. Ngoài ra laser Excimer còn có thể điều trị được cả cận, viễn và loạn thị.

5. Làm thế nào để chẩn đoán sơ bộ mắt có tật khúc xạ và quản lý các em có tật khúc xạ?

(Xem tiếp kỳ sau)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Ban Biên tập báo Sức Khỏe & Đời Sống cuối tuần đã nhận được thư và bài của các bạn:

Cao Phan Bình, Lê Hữu Cảnh, Tô Thị Diệp, Đặng Văn Biển, Trần Hoài Linh, Phan Thanh Dũng, Nguyễn Thị Thủy Hoa, Trần Thị Mai, Trương Văn Nhì, Nguyễn Văn Trường, Trần Nam Cường, Đào Xuân Thái, Hoàng Phú Hiệp (TPHCM); Phi Hậu, Mạnh Dũng, Trần Thái Tuấn (Bình Dương); Dương Thị Sáng, Trương Thành Thông, Hồ Sĩ Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh (Đồng Nai); Đỗ Đăng Cường (Phước Yên); Nguyễn Mạnh Quý, Phạm Như Lan, Cao Minh Tân (Lâm Đồng); Đinh Thị Liên, Trần Thị Ngọc Vân (Khánh Hòa); Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Kiều Trang (Gia Lai); Cô May, Phạm Thị Minh Anh, Trần Nguyễn Khanh (Hà Nội); Châu Văn Thiệt, Đào Thị Cẩm Tú, Trần Thành Tài, Nguyễn Thị Cẩm Yên (Hải Phòng).

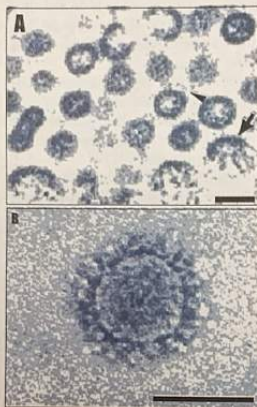
BBT xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các bạn.

Mời bạn đọc truy cập báo SK&ĐS cuối tuần (miễn phí) ở địa chỉ: <http://www.suckhoeodoisong.saiognet.vn>

Vén màn bí mật tác nhân virus gây SARS

các bước tiến ngoạn mục của y - sinh học hiện đại

Chi một thời gian ngắn, chưa đầy 1 tháng kể từ khi phát hiện sự bùng nổ có nguy cơ toàn cầu dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp nặng - severe acute respiratory syndrome), các nhà y - sinh học đã đưa ra ánh sáng thủ phạm gây SARS, đó là một loại coronavirus hoàn toàn mới lạ so với các coronavirus có nguồn gốc từ người và động vật được biết từ trước đến nay. Phát hiện này được cả Trung tâm Kiểm soát bệnh (CDC) tại Hoa Kỳ và Trung tâm Chuẩn thức Quốc gia các Bệnh nhiệt đới tại Hamburg (Đức) cùng công bố bằng hai bài nghiên cứu đăng vào ngày 10/4/2003 trên tạp chí trực tuyến "The New England Journal of Medicine". Nghiên cứu của CDC được thực hiện trên các mẫu bệnh phẩm lấy từ 18 bệnh nhân (6 từ Hồng Kông, 10 từ Việt Nam, 1 tại Canada và 1 tại Đài Loan) bằng 3



Corona virus gây SARS nhìn thấy qua kính hiển vi điện tử (A. Từ bệnh phẩm, B. Phòng đại lớn hơn). Vạch đen trong hình tương đương 100nm.

TS. BS. PHAM HÙNG VÂN

(Giảng viên Bộ môn Vi sinh, khoa Y, Đại học Y Dược TPHCM)

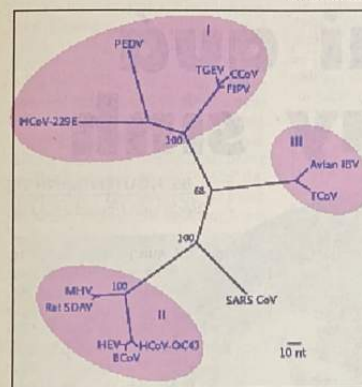
phương pháp: Cấy phân lập virus trên tế bào Vero E-6; Xét nghiệm PCR phát hiện virus và Thử nghiệm miễn dịch (ELISA và miễn dịch huỳnh quang) đã xác định được thủ phạm là coronavirus qua kết quả dương tính của một, hai hay cả ba phương pháp trên. Trong công trình này, trên bệnh phẩm của cả 10 bệnh nhân Việt Nam, xét nghiệm PCR đều cho kết quả [+], có 3 trường hợp cấy ra được virus. Đặc biệt có 1 bệnh nhân tử vong tại Hồng Kông, phòng thí nghiệm đã phân lập được coronavirus từ mô bệnh là thận và phổi lấy được qua tử thi (mô tử thi). Kết quả này càng có ý nghĩa khẳng định coronavirus là tác nhân gây bệnh vì đã được tìm thấy trực tiếp từ mô bệnh. Nghiên



Phòng thí nghiệm của GSC, nơi đã thực hiện việc giải mã hoàn toàn bộ gen của virus gây SARS.

cứ tại phòng thí nghiệm Hamburg chủ yếu thực hiện bằng nuôi cấy phân lập virus trên tế bào Vero E-6 và kỹ thuật PCR với các bệnh phẩm lấy từ một hành khách là bác sĩ và 2 người nhà cùng đi theo. Vị bác sĩ này đã chữa trị cho một bệnh nhân bị viêm phổi không điển hình tại Singapore và ông phải dừng chân tại Frankfurt vì ngã bệnh SARS trên máy bay của hãng không Singapore. Các kết quả cũng cho thấy thủ phạm là coronavirus.

Điều đáng nói trong cả hai công trình là khi giải trình tự sản phẩm



Hình vẽ cho thấy sự khác biệt di truyền của coronavirus gây SARS so với ba nhóm coronavirus đã biết có nguồn gốc từ người và động vật. Vạch đen trên hình biểu thị tỷ lệ khác biệt so sánh trình tự nucleotide.

PCR từ coronavirus gây SARS (được CDC đặt tên là *Urbani SARS-associated coronavirus* để tưởng nhớ đến bác sĩ Carlo Urbani, người đã phát hiện SARS và đã chết vì SARS) và đem so sánh đối chiếu với các coronavirus có nguồn gốc từ người và động vật, các nhà khoa học đã xác nhận đây là loại coronavirus có đặc điểm di truyền hoàn toàn mới và khác biệt. Hai công trình nghiên cứu cũng cho thấy triển vọng có thể sớm đưa ra các bộ thử nghiệm miễn dịch và sinh học phân tử (PCR) để giúp chẩn

doán xác định SARS trên bệnh nhân. Riêng CDC cho biết các thử nghiệm miễn dịch có thể sẽ được áp dụng trên toàn Hoa Kỳ trong một thời gian rất gần.

Một bước tiến ngoạn mục nữa vừa được công bố vào ngày 12/4/2003, đó là các nhà khoa học của Trung tâm Khoa học gen Michael Smith (Genome Science Center = GSC) tại Vancouver, British Columbia đã giải mã được hoàn toàn bộ gen của coronavirus gây SARS. Kết quả nghiên cứu đã công bố bộ gen của virus này là một sợi đơn đường RNA với 29.736 nucleotides. Trình tự này đã được đưa lên mạng với số hiệu AY274119 để các nhà khoa học trên toàn thế giới có thể tải xuống máy tính của mình thông qua địa chỉ của mạng NCBI hay từ địa chỉ <http://www.bcgsc.ca/bioinfo/SARS/>. Việc nhanh chóng giải mã được trình tự coronavirus gây SARS là kết quả một quá trình làm việc cắt lức của các nhà khoa học tại một phòng thí nghiệm trang bị cực kỳ hiện đại của GSC, với toàn bộ thiết bị giải trình tự gen trên một dây chuyền hoàn toàn tự động. Việc đưa lên mạng trình tự coronavirus gây SARS là hết sức cần thiết vì sẽ giúp các nhà khoa học trên toàn thế giới biết được bản chất của tác nhân virus này để cùng nhau tìm giải pháp chặn đứng nguy cơ toàn cầu của dịch SARS (mà với tỷ lệ tử vong hiện nay lên đến 5% thì quả thực là một đại dịch).

TÌNH HÌNH VỀ CÁC XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN SARS

BS. NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN

(Sydney - Australia)

Hiện mạng lưới 11 phòng xét nghiệm của WHO đang tích cực làm việc từng giờ, tuy nhiên bước đầu gặp phải một số trở ngại. Các xét nghiệm chẩn đoán hiện đã có sẵn nhưng tất cả đều có mặt hạn chế khi được sử dụng như một công cụ nhằm nhanh chóng kiểm soát vụ bùng phát SARS.

Xét nghiệm ELISA phát hiện các kháng thể có độ tin cậy nhưng chỉ có giá trị sau khi phát hiện trước khi có nguy cơ lây lan sang người khác. Xét nghiệm thứ hai là một xét nghiệm bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang (IFA), phát hiện các kháng thể có độ tin cậy sau khi nhiễm bệnh 10 ngày,

nhưng lại là một xét nghiệm chậm để so sánh kết quả vì cần có thời gian cho virus phát triển được sau khi nuôi cấy. Xét nghiệm phân tử PCR sẵn có hiện nay dùng phát hiện chất liệu di truyền của virus gây SARS rất hữu ích để chẩn đoán bệnh trong các giai đoạn sớm của nhiễm trùng, tuy nhiên lại có độ âm tính giả cao, nghĩa là nhiều người thực sự có chứa virus trong người nhưng lại không phát hiện được, dẫn đến sự chủ quan nguy hiểm về tình trạng an toàn giả tạo do virus rất dễ lây lan theo đường tiếp xúc gần giữa người với người.

CÁC BÀ MẸ CẦN BIẾT

CÁCH TÍNH TUỔI THAI

Thai quá ngày sinh còn gọi là thai già tháng, thai quá dự kiến sinh... để mô tả hiện tượng thai nhi đã đến ngày sinh nhưng chưa chào đời. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa các cách gọi này. Có thể hiểu như sau: Thai già tháng là những thai quá dự kiến sinh. Sức sống của thai nhi trong bụng mẹ suy giảm, nên lấy thai ra bằng phẫu thuật; Thai quá dự kiến sinh và thai quá ngày sinh được hiểu như nhau, là những thai quá chín tháng mười ngày như dân gian thường gọi, hay quá 41 tuần hoặc 280 ngày theo cách tính của y học.

Những ngày thấy kinh lần cuối hay kỳ kinh cuối cùng xảy ra lúc nào là một câu hỏi luôn được đặt ra mỗi khi khám thai. Căn cứ vào ngày đầu tiên của kỳ kinh, thấy thuốc sẽ tính được tuổi thai. Cách tính tuổi thai dựa vào số tuần không có kinh của thai phụ. Ví dụ: Nếu một phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn 28 ngày, kinh lần cuối thấy từ ngày 1 - 5/1/2003. Người phụ nữ này đi khám sau khi chậm kinh hai tuần. Tuổi thai sẽ được tính là: $4+2=6$ tuần. Nhiều người không đồng ý với cách tính này vì cho rằng đây không phải là tuổi thai thật. Đúng như vậy, ngày thụ thai thật không phải là ngày có kinh đầu tiên mà là những ngày giữa của chu kỳ kinh. Tuy nhiên, cách tính trên được chấp nhận vì không mấy ai biết chắc ngày mình có thai. Hơn nữa nó khá thuận lợi khi thai phụ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Cũng căn cứ vào ngày đầu kỳ kinh cuối cùng mà thấy thuốc có thể đưa ra dự kiến ngày sinh. Cách tính như sau: Tháng cộng thêm 9, ngày cộng thêm 7 (không phải 10, do có những tháng 31 ngày). Với cách tính này thì dự kiến ngày sinh của thai phụ trên là: Tháng = $1+9=10$, ngày $1+7=8$. Ngày dự kiến sinh là 8/10/2003. Đây không phải là ngày sinh thật mà chỉ là ngày dự

Khoảng 5 năm trở lại đây, các bệnh viện sản thường gặp phải một hiện tượng, đó là thai quá dự kiến sinh. Trước đây vấn đề này xuất hiện rất ít và dễ bị bỏ qua. Thời gian gần đây, do mặt bằng y tế được cải thiện, trình độ dân trí nâng cao nên các thai phụ đã đi khám thai thường xuyên hơn, nhờ vậy các thầy thuốc sản khoa có cơ hội phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ quá ngày sinh. Việc phát hiện và điều trị sớm đã làm giảm đáng kể tỷ lệ chết thai cũng như tử vong sơ sinh. Tuy nhiên do những hiểu biết về thai quá ngày sinh còn hạn chế, nhiều thai phụ đã phải mang một vết mổ không đáng có.

Thai quá ngày sinh

BS. NGUYỄN MANH TRI

(Bệnh viện Phụ sản Hà Nội)



kiến sinh. Với giới hạn này, nếu sau ngày dự kiến sinh chưa thấy chuyển dạ thì được gọi là thai quá ngày sinh hay đầy đủ hơn là thai quá dự kiến sinh. Những thai này sẽ được theo dõi bằng một chế độ khác và thời gian hen tái khám cũng sẽ gần hơn.

Dự kiến sinh được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Đến ngày dự kiến sinh, người phụ nữ không có kinh khoảng 40 đến 41 tuần. Như vậy tuổi thai là 40 đến 41 tuần. Trên thực tế không phải thai phụ nào cũng chuyển dạ đúng vào ngày dự kiến sinh. Nếu cuộc chuyển dạ xảy ra ở tuổi thai 38 đến 42 tuần

được coi là thai đủ tháng. Thai nhi dưới 38 tuần được coi là non tháng. Thai nhi trên 42 tuần sẽ được tính là thai già tháng. Không ít thai phụ, khi được hỏi thay vì trả lời ngày đầu tiên lại trả lời ngày cuối cùng của kỳ kinh. Ví dụ như thai phụ trên không nói ngày 01 tháng 01 mà nói ngày 05 tháng 01. Câu trả lời này không chính xác. Vì vậy một số cơ sở y tế không lấy giới hạn 42 tuần mà lấy giới hạn 41 tuần để tính. Cứ trên 41 tuần được tính là thai già tháng. Cách tính này không đúng song có ý nghĩa thực tiễn cao, cảnh báo sớm nhằm giảm tình trạng bỏ sót những trường hợp thai quá dự kiến sinh do lẫn lộn ngày kinh.

Cách tính tuổi thai vẫn áp dụng như vậy cho các trường hợp có chu kỳ kinh dài trên 35 ngày hoặc ngắn hơn 21 ngày. Khi đến ngày dự kiến sinh mà chưa chuyển dạ, thấy thuốc sẽ căn cứ vào yếu tố chu kỳ kinh để đưa ra hướng thăm khám. Nếu chu kỳ kinh đều, dù ngắn hay dài đều có hướng để xử trí. Phức tạp hơn là

khi gặp thai phụ có chu kỳ kinh nguyệt không đều, thất thường, không nhớ ngày kinh; Hoặc đôi khi có những thai phụ kinh đều nhưng không nhớ chính xác những ngày kinh lần cuối, gây khó khăn cho thấy thuốc khi thăm khám và quyết định hướng xử trí tiếp theo (Trong khi tỷ lệ thai phụ không nhớ ngày kinh cuối cùng chiếm tới 10%).

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN THAI QUÁ NGÀY SINH

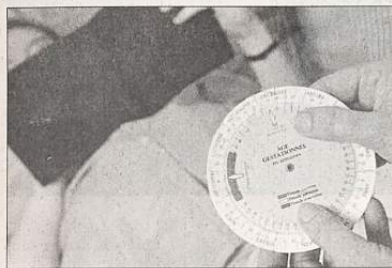
Các trường hợp không nhớ ngày kinh sẽ căn cứ vào siêu âm 3 tháng đầu để xác định tuổi thai và dự đoán ngày sinh. Chú ý một điều rằng siêu âm 3 tháng đầu cho phép sai số 1 tuần, 3 tháng giữa cho phép sai số 2 tuần và 3 tháng cuối cho phép sai số 3 tuần. Như vậy không nên lấy siêu âm 3 tháng cuối để dự kiến ngày sinh. Siêu âm sẽ căn cứ vào các phép đo chiều dài để đánh giá tuổi thai, thông thường là đường kính lưỡng đỉnh (2 xương đỉnh), chiều dài xương đùi... Hai thai phụ sinh con đủ tháng nhưng một người sinh con

ảnh siêu âm của thai đủ tháng. Việc theo dõi nhóm thai phụ không nhớ ngày kinh cuối nhìn chung sẽ tốn kém hơn.

Thai già tháng ra đời sẽ gặp nhiều rủi ro hơn thai đủ tháng. Có thể hình dung các thai này giống như người già yếu, không khỏe như những người trưởng thành. Trao đổi chất giữa mẹ và thai nhi ở những thai già tháng kém đi, cung cấp dinh dưỡng và oxy thiếu. Rất hay gặp hiện tượng chết thai trong tử cung. Khi ra đời, các thai già tháng hay gặp các bệnh về đường hô hấp, điều nhiệt... nguy cơ tử vong cũng cao hơn. Những không phải thai quá ngày sinh nào cũng sẽ là thai già tháng và yếu, cũng giống như không phải người cao tuổi nào cũng yếu ớt.

Siêu âm là một phương pháp để theo dõi thai quá dự kiến sinh. Lượng nước ối là căn cứ chính để theo dõi. Nếu kết quả siêu âm cho biết lượng nước ối trung bình hay bình thường, các thai phụ sẽ được

hen tái khám sau 24 đến 48 giờ. Nếu lượng nước ối thấp, thai phụ nên vào bệnh viện theo dõi. Một vài trường hợp lượng nước ối quá ít thì phải mổ lấy thai ngay, còn lại đa số sẽ được thực hiện một thử nghiệm (test). Cách thử như sau: Thai phụ



Bảng tính ngày dự sinh cho sản phụ.

nặng 2.500g, một người sinh con nặng 4.000g, tuy nhiên không thể nói tuổi thai của trẻ 2.500g nhỏ hơn tuổi thai trẻ 4.000g. Cũng có nhiều trường hợp không siêu âm 3 tháng đầu hoặc có những thai phụ không còn giữ số theo dõi, việc xác định ngày sinh sẽ rất khó khăn. Các thai phụ này phải chấp nhận vào bệnh viện nằm nội trú khi trên siêu âm các đường kính thai trong giới hạn đủ tháng. Một vấn đề nan giải nữa là nếu thai phụ không nhớ ngày kinh cuối cùng, thai lại kém phát triển, các đường kính thai nhỏ hơn tuổi thai thật thì sẽ không có được hình

sẽ được kích thích tạo con co tử cung giống như khi chuyển dạ. Nếu thai nhi chịu đựng được, coi như thử nghiệm âm tính, thai phụ tiếp tục được theo dõi chờ chuyển dạ và làm lại thử nghiệm này sau 24 đến 48 giờ. Các thai phụ này vẫn có thể sinh theo đường tự nhiên. Nếu thai nhi không chịu đựng được, biểu hiện bằng những thay đổi bất thường của nhịp tim thai, thử nghiệm có kết quả dương tính, thai nhi sẽ được lấy ra bằng phẫu thuật.

Một số trường hợp thử nghiệm âm tính, thai phụ sẽ chờ chuyển

dạ tự nhiên. Khi kết hợp với siêu âm tiến lượng trong lượng con như các đường kính của thai là đủ tháng, thai phụ sẽ được chủ động gây chuyển dạ. Với cách làm này, rất nhiều thai phụ không chuyển dạ tự nhiên sẽ được khởi động chuyển dạ và cuộc sinh nở vẫn suôn sẻ. Điều đó tránh được sự căng thẳng cho thai phụ, gia đình và nhân viên y tế. Tuy nhiên, gây chuyển dạ không đơn giản, chỉ được áp dụng tại các bệnh viện, nơi có khả năng phẫu thuật nếu bất thường xảy ra.

Các trường hợp không nhớ kỳ kinh cuối, khi siêu âm nghi ngờ đủ tháng cũng nên vào bệnh viện theo dõi như vậy. Siêu âm màu ra đời cho phép đánh giá dòng máu chảy trong cuống rốn, tử cung..., giúp việc chẩn đoán thai già tháng thuận lợi hơn. Nếu sự trao đổi chất giữa mẹ và thai nhi thông qua bánh nhau, dây rốn thay đổi hoặc thai có tiền lượng xấu, việc lấy thai sẽ đặt ra. Siêu âm màu ứng dụng rất hiệu quả trong các trường hợp nghi ngờ quá ngày sinh kết hợp suy dinh dưỡng trong tử cung. Siêu âm màu khác siêu âm 3 chiều và khá đắt tiền, không phải cơ sở y tế nào cũng có được nên việc ứng dụng cho thai quá ngày sinh còn chưa rộng rãi.

KẾT LUẬN

Tóm lại, thai quá dự kiến sinh chưa hẳn đã là thai già tháng. Gia đình thai phụ không nên lo lắng thái quá để rồi gây áp lực buộc nhân viên y tế phải phẫu thuật lấy thai. Việc theo dõi thai quá dự kiến sinh dựa trên hỏi lâm sàng và siêu âm. Khi có những nghi ngờ về lượng ối nên vào nội trú bệnh viện. Các thử nghiệm (test) nếu âm tính (tức không suy thai), thai phụ cứ tiếp tục chờ chuyển dạ hoặc bình tĩnh nếu được gây chuyển dạ, sinh nở an toàn là không nhỏ.

Với những thông tin đã trình bày, mong các phụ nữ sắp làm mẹ có được khái niệm rõ hơn về thai quá dự kiến sinh, thai già tháng. Từ đó sẽ có thái độ bình tĩnh khi gặp phải tình huống tương tự, đồng thời cũng lấy đây làm căn cứ để thông tin lại nếu bạn thân thấy chưa ứng ý trước cách thăm khám và giải quyết của thầy thuốc. ■

ĐIỀU CẦN QUAN TÂM

nói là lạnh hoặc ngược lại. Chất độc gây chết người đã được xác định là Tetratoxin, là một loại độc tố thần kinh nên gây tỷ lệ tử vong rất cao nếu người ăn không được cấp cứu kịp thời và điều

hủy; Đun sôi ở 100°C sau 6 giờ mới giảm một nửa, ở 200°C trong 10 phút mới bị hủy hoàn toàn. Như vậy để hủy độc tính hoàn toàn, ít ai đun nấu cả tới 12 giờ hay rán cả ngập trong mỡ tới 20

Cần hết sức thận trọng với cá nóc

Cá nóc là nguyên nhân gây tử vong rất cao trong số các vụ ngộ độc thực phẩm (NDTP) mấy năm gần đây. Theo phân tích các vụ NDTP do cá nóc từ năm 1999 đến hết quý 1 năm 2001, số vụ là 33, số người mắc - 197, số người tử vong - 41. Trong số 33 vụ NDTP do cá nóc thì do cá nóc tươi là 23 vụ (chủ yếu xảy ra tại các gia đình sống ở vùng biển), còn do cá nóc khô là 10 vụ. Nói cách khác, trung bình 06 người mắc/vụ và 1,24 người tử vong/vụ.

BS. NGUYỄN VĂN DUNG

(Cục Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm)

Một số trường hợp điển hình

Ngày 31/3/1999 tại Nghệ An có 11 người ăn thì 06 người chết; Ngày 10/1/2000 tại Hà Tĩnh có 03 người chết trong số 07 người ăn; Ngày 28/3/2000 - 3 người chết/4 ca; Ngày 25/11/2000 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 chết/9 ca; Ngày 28/3/2001 tại Quảng Ngãi, 3 chết/4 ca. Nguyên nhân ngộ độc không chỉ bởi cá nóc mà còn liên quan đến cá nóc! Có một vụ đáng chú ý ở Quảng Ngãi: rạng sáng 21/1/2002, ba người thuộc một gia đình ở thị trấn Chợ Chùa phải vào viện cấp

cứu vì ngộ độc do... cá cơm được bày bán chung với cá nóc. Ngày 2/12/2002, tại xã Cầu Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, một gia đình cả 9 người đã bị ngộ độc do ăn cá khô có lẫn cá nóc, trong đó 3 người chết là vợ, chồng và một con gái 6 tuổi. Tất cả những người ngộ độc liên quan đến cá nóc, ngoài các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, ói mửa... đều có chung một triệu chứng phân biệt là rối loạn cảm giác vùng miệng như tê môi, tê lưỡi. Khi đó, cảm giác thường không phân biệt được nóng, lạnh, vật nóng thì

trị đúng. Tuy vậy, Tetratoxin được dùng một cách chọn lọc trong ngành y để gây tê, gây mê, giảm đau, chữa một số bệnh tim mạch, ung thư v.v... Vì giá trị của nó và phương pháp chiết suất phức tạp, giá thành chất độc này rất cao, lên tới 27 triệu USD/1kg. Trong cá nóc chất độc này có chủ yếu ở các cơ quan như: gan, thận, ruột, túi, cơ quan sinh sản (trứng cá, buồng trứng, túi tinh), mắt, mang, máu, da. Độc tính của Tetratoxin rất bền vững: Trong dung dịch acid clohydric 0,2-0,5% sau 8 giờ mới bị phân

phân (cộng thêm 10 phút để nhiệt độ trung tâm trong thịt cá cũng đạt tới nhiệt độ sôi!).

Các giả thiết về cơ chế gây ngộ độc của cá nóc

Có hai giả thiết khác nhau về cơ chế gây ngộ độc bởi ăn cá nóc. Ý kiến thứ nhất cho rằng: Tetratoxin là một tiền chất của Tetratoxin, bản thân nó là một chất không độc, chỉ biến chất thành Tetratoxin khi cá bị ướp, và đập. Hiện nay, Nhật Bản đã xác định được 22 loài cá nóc không gây ngộ độc nếu không bị va đập, ướp hoặc được bảo

Appeton Chứa Taurine Giúp Con Bạn Phát Triển Trí Não



Taurine rất cần thiết cho não và hệ thần kinh trung ương. Taurine bảo vệ và ổn định màng tế bào giúp phát triển trí não. Tuy nhiên, những bé không bú sữa mẹ có thể có lượng Taurine thấp. Bổ sung thêm Appeton có chứa Taurine vào khẩu phần ăn hàng ngày của bé sẽ giúp phát triển tốt trí não của con bạn.

Thành phần: Appeton chứa Taurine và các Vitamin.

Chỉ định: Giúp phát triển tốt trí não và thị lực, bổ sung chất dinh dưỡng cho thời kỳ tăng trưởng.

Liều dùng: Trẻ em: (dưới 4 tuổi): 2,5 ml mỗi ngày

Trẻ em trên 4 tuổi: 5 ml mỗi ngày

Chống chỉ định: Không dùng Appeton With Taurine cho phụ nữ có thai, không dùng chung các thuốc khác có chứa Vitamin A.D.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nhà Sản Xuất: KOTRA PHARMA (M) SDN BHD

<http://www.appeton.com>

Nhà Phân Phối: Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Tân Quý, 33 Tân Quý Khố, P. Tân Bình, Q.1, TP. HCM

ĐT: (84-8) 848 3382 - 848 1096 **FAX:** (84-8) 848 0597

Email: maycosmedic@hcm.vnn.vn



APPETON

Siro Appeton chứa 60 ml và 120ml, hiện có bán tại các nhà thuốc

Số DK: VN - 7342-03

Mẫu đăng nhận hồ sơ đăng ký OC trước của Cục QL/DVN

Số 20203/QLD-TT ngày 17 tháng 03 năm 2003

Sữa mùa thu...

DẦU KHUYNH DIỆP OPC

Thành phần chính: Eucalyptol

Dùng trong các trường hợp nhức đầu, chóng mặt, cảm cúm, sổ mũi, ho, tức ngực, đau bụng, say tàu xe, nhức mỏi, sưng tấy, bị muỗi và các côn trùng khác đốt.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

OPC



CTY CP DƯỢC PHẨM OPC



CABOVIS®

**Thanh nhiệt, giải độc,
Trị các chứng do nóng nhiệt
trong người gây nên**

Thử uống CABOVIS trước khi dùng kháng sinh!

牛
黄
解
毒



CHỈ ĐỊNH:
Thanh nhiệt giải độc, trị các chứng do nóng nhiệt trong người gây nên như: viêm họng, sưng đau chân răng, lở loét miệng, mụn nhọt, táo bón...

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Người lớn: 2 viên x 2-3 lần/ngày.
Uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho phụ nữ có thai.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- | | |
|-----------------------------|-------|
| Calculus Bovis artificialis | 5mg |
| Gypsum Fibrosum | 200mg |
| Rhizoma Rhei | 200mg |
| Radix Scutellariae | 150mg |
| Radix Platycodi | 100mg |
| Borneolum syntheticum | 25mg |
| Radix Glycyrrhizae | 50mg |



OPC

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo số: 260 và 261/02/QLD-TT ngày 17-9-2002

AMIPLEX® Tab. 500mg

Casein Hydrolysate 500mg

CUNG CẤP 18 ACID AMIN CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ

Amiplex, một phức hợp có nồng độ cao tỷ lệ cân bằng các amino acid tự do lấy từ casein thủy phân từ enzyme của tuyến tụy được điều chế đặc biệt để tăng tính khả dụng sinh học. Đây là một nguồn dinh dưỡng có chứa 18 amino acid trong đó có 10 amino acid thiết yếu có lợi thể là hấp thu nhanh và duy trì nito cao hơn so với các dạng hỗn hợp tự do khác.

TÍNH CHẤT:

Phenylalanine và Tyrosine là tiền chất của các chất dẫn truyền thần kinh catecholamine là dopamin và noradrenalin. Chúng kích thích hormon tăng trưởng, đẩy mạnh hoạt động của hệ miễn dịch. Đồng thời, các amino acid này giúp ích trong việc điều trị một vài chứng suy nhược. Tryptophan được sử dụng như là một chất tạo giấc ngủ tự nhiên, do vai trò của nó được xem như là tiền chất của serotonin là chất dẫn truyền thần kinh trung ương. Methionine là chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ các vitamin hormon tăng trưởng và tham gia điều hòa quá trình chuyển hóa của cơ thể. Đây là một trong các Amino acid thiết yếu thường thiếu trong chế độ ăn kiêng, và cũng là chất được sử dụng trong điều trị chứng Herpes đơn giản.



Amiplex được chỉ định dùng trong các trường hợp loạn dưỡng, cơ thể suy yếu, mệt mỏi, bệnh nhân trong thời kỳ trị bệnh và thời kỳ dưỡng bệnh, bệnh nhân bệnh lao và thiếu năng gan, cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, tăng cường sức khỏe cho các vận động viên.

Chống chỉ định: Không có.
Tác dụng phụ: dùng đủ liều không có phản ứng phụ.
Liều dùng: Người lớn 1-2 viên mỗi lần, 3 lần/ngày.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi dùng.



SDK: VN-4221-00

Thuốc có bán tại các nhà thuốc tây.
Nhà sản xuất: **KOREAN DRUG CO., LTD**
Seoul, Korea
Số giấy phép: 288a-02/QLD-TT
Cấp ngày: 17/10/2002

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

(DONG THAP MEDICAL IMPORT-EXPORT CORPORATION)



234A QL.30 - Mỹ Trà - TX. Cao Lãnh - Đồng Tháp
ĐT: 84.67. 852008 - 852278 * Fax: 84.67. 851270

Website: www.domesco.com * Email: domc@hcm.vnn.vn



Povidon iodin 10% DOBENZIC

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN



THÀNH PHẦN
- Povidon iodin 10 g
- Tá dược vừa đủ 100 ml

CHỈ ĐỊNH
- Sát trùng các vết thương bề mặt da.
- Chuẩn bị để sát trùng trước khi phẫu thuật.
- Phụ nữ lặn, lặn ben, nước ăn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Người có tiền căn không dung nạp Iod.
- Trẻ sơ sinh (từ 0 đến 1 tháng tuổi) nhất là trẻ sinh non.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG
Chỉ dùng ngoài da. Có thể dùng ngay hoặc dùng sau khi pha loãng.
- Khi dùng rửa vết thương: Pha loãng 1/10 với nước.
- Khi dùng rửa vết thương bằng cách nhỏ giọt: Pha loãng theo tỷ lệ 2% với nước.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Phẫu tiếp nhận hồ sơ số: 555/02/QLD-TT, ngày 24/12/2002



TRẺ ĐỀ THIẾU THĂNG, TRẺ NHỎ CHĂN AN, SUY DINH DƯỠNG, BỆNH NIÊM KHUẨN TÁI LẠI, RỐI LOẠN TIÊU HÓA SAU KHI PHẪU THUẬT, ĐƯỜNG BỆNH NẶNG, SUY NHƯỢC Ở NGƯỜI LỚN VÀ NGƯỜI GIÀ.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Phẫu tiếp nhận hồ sơ số: 162/03/QLD-TT, ngày 28/02/2003

DORAGON® (Pheretima aspergillum)



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa
- Cao địa long 5/1 (Pheretima aspergillum extract) 500 mg
- Tá dược vừa đủ 01 viên
CHỈ ĐỊNH: Làm giảm nhanh cảm giác ngứa, làm khô vết thương, tăng khả năng thích nghi của cơ thể trong những điều kiện làm việc gắng sức.
CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Uống 2 viên/lần, ngày 3 lần.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Số phẫu tiếp nhận hồ sơ: 163/03/QLD-TT, ngày 28/02/2003

DOGARLIC® TỎI, NGHỆ THIÊN NHIÊN - TINH KHIẾT

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa
- Cao tỏi 5/1 (Allium sativum extract) 300 mg
- Cao nghệ 4/1 (Curcuma longa extract) 25 mg
- Tá dược vừa đủ 01 viên
* Mỗi viên tương đương 1500 mg tỏi tươi.
CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu, điều hòa triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch.
CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống 102-4 viên/ngày, chia 2 lần trước bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Mỗi viên tương đương 1500mg tỏi tươi



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Số phẫu tiếp nhận hồ sơ: 164/03/QLD-TT, ngày 28/02/2003



SĐK: VHA-431-01 - Viên nén
VHA-1746-98 - Viên bao phim
VHA-3092-00 - Viên nang

quần đông lạnh nhanh ngay sau khi vớt đánh bắt. Như vậy, giả thiết này chưa khẳng định được 22 loài cá nóc trên (được phân loại là cá nóc vì có hình dáng tương tự) là hoàn toàn không độc. Giả thiết thứ hai cho rằng, loài cá náo được phân loại là cá nóc đều có thể gây ngộ độc và có chứa Tetradoxin không chỉ trong phủ tạng mà còn trong thịt cá. Cả hai giả thiết này đều thân trong trong trường hợp cá nóc đã chết hoặc bị va đập, bị ươn! Ngay trong một cuốn cẩm nang về cá nóc được xuất bản tại Nhật Bản năm 1983, người ta đã chỉ ra 22 loài cá nóc có thể ăn được, nhưng cũng lưu ý phải là các loài cá nóc được đánh bắt ở một số vùng biển nhất định trên thế giới; Được đông lạnh nhanh ngay sau khi đánh bắt lên bờ (còn sống) và còn nguyên vẹn để độc tố không kịp chuyển sang thịt cá; Để nguyên da và đầu để chuyển gia nhân dạng có đúng là loài cá ăn được hay không.

Một trường phái khác ủng hộ việc ăn thịt cá nóc cho rằng: Thịt cá nóc thuộc một trong 22 loài đã được Nhật Bản phân loại như trên hoàn toàn không có độc và trong điều kiện muối mắm tự nhiên, độc tính của Tetradoxin vẫn bị phân hủy (Người dân Việt Nam vẫn dùng cá nóc làm mắm nhưng không ai bị ngộ độc hay chết vì ăn mắm cá nóc cả). Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học đã cho biết như sau: Cá nóc trứng được trộn với muối và để sau 2,5 năm vẫn còn độc tố tuy có giảm. Tiếc rằng nghiên cứu không được tiến hành đầy đủ và lâu hơn nữa để khẳng định thêm rằng: Độc tố có thể bị phân hủy đến liều an toàn sau bao lâu và trong điều kiện cụ thể nào?

Nhưng cũng trong cuốn cẩm nang nói trên, dù đối với thịt của một trong 22 loài cá nóc ăn được thịt, điều kiện chế biến cũng rất nghiêm ngặt: Cá nóc đông lạnh phải được bảo quản ở dưới 20°C trong một tháng; Khi rửa đông phải giám sát và kiểm tra nhiệt độ trung tâm của thịt trong phòng lạnh 3-4°C hoặc ngâm, xả nước mát, nếu tới 0°C thì phải chế biến và nấu ngay. Tại nước ta, chưa có tàu đánh bắt cá náo được trang bị máy cấp đông tới âm 40°C mà chủ yếu là dùng nước đá để ướp cá! Mặt khác, Nhật Bản quy định: Người hành nghề chế biến cá nóc, phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực hành và được thị trường thành phố cấp giấy phép hành nghề.

Qua các trình bày trên, ta thấy khoa học vẫn chưa lý giải và khẳng định được những cơ chế gây ngộ độc bởi chất độc của cá nóc. Riêng ở nước ta, vẫn chưa có chuyên gia phân biệt, chọn lựa cá nóc cho thịt ăn được, cũng như chưa có quy định về quy trình từ lúc đánh bắt đến khi cung cấp cho người ăn, chính sách pháp luật còn chưa rõ ràng về việc cấm kinh doanh cá nóc. Vì vậy tốt nhất là chúng ta vẫn cần hết sức thận trọng với cá nóc!

SỐ 224 • THÁNG 4/2003

TIN NGẮN TRONG NƯỚC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ Y TẾ NIỆM KỶ IV (2003-2008)

Được tổ chức trong 2 ngày 10-11/4/2003 với sự tham dự của PGS. TS. Trần Thị Trung Chiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và BS. Đoàn Thủy Ba, Anh hùng Lao động, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và 141 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên công đoàn của các đơn vị trực thuộc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2003-2008) bao gồm 15 đại biểu với mục tiêu chung là: tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVC - LĐ của công đoàn khối cơ sở Bộ Y tế vững mạnh về mọi mặt: có nhận thức chính trị cao, giỏi về chuyên môn, tham gia thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân... Đại hội cũng thông qua danh sách 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu (ĐHĐB) liên đoàn Lao động TP và 18 đại biểu dự ĐHĐB công đoàn y tế Việt Nam khóa X.

Nhân dịp này, công đoàn khối đã trao chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh cho 16 đơn vị và 88 giấy khen cho đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ngoài ra nhiều đơn vị trực thuộc còn được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ XU HƯỚNG NGÀY Càng GIA TĂNG
Vừa qua, Hội Nội tiết - Đái tháo đường VN đã phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo đường TPHCM tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần 2 với sự tham gia của 650 đại biểu là GS, BS của 163 đơn vị y tế thuộc 46 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo Hội nghị, bệnh đái tháo đường có xu hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Nếu năm 1992 chỉ có 2,62% dân số trên 15 tuổi mắc bệnh thì đến năm 2000 đã tăng lên 3,2%. Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh là: tuổi cao (nhiều nhất từ 50 tuổi trở lên), nữ có thai to, béo phì, chế độ ăn uống không hợp lý...

T.Q

Liệu pháp vi lượng đồng cân (homeopathy) là phương thức điều trị bệnh nhân bằng cách cho người đó sử dụng một chất (ở dạng pha loãng cực độ nhưng vẫn còn hoạt tính) nhằm gây ra những triệu chứng, rối loạn giống hệt như trước đó người ấy đã có. Liệu pháp này được Christian Friedrich Samuel Hahneman, một thầy thuốc người Đức phát hiện vào năm 1810.

Thường thức về liệu vi lượng đồng cân

Nguyên tắc chủ yếu của liệu pháp vi lượng đồng cân là gì?

Đó là việc chứng minh và xác định rằng mọi chất có khả năng gây ra một số triệu chứng ở người bình thường lại có thể chữa trị được một người bệnh có những triệu chứng giống hệt thế. Khi đối mặt với một tác nhân gây bệnh (ví khuẩn), liệu pháp đối cân (còn gọi là đối bệnh: allopathy) sẽ tìm cách ngăn chặn tác hại của yếu tố gây bệnh, ngược lại liệu pháp vi lượng đồng cân (hoặc đồng bệnh: homeopathy) thì tìm cách kích thích những phản ứng bảo vệ của cơ thể đang bị gây hại, nhằm giúp cơ thể phát triển tất cả những tiềm năng chống đỡ sẵn có. Dựa trên nguyên tắc này, khi chữa trị một số triệu chứng (phù, đau nhức...) do vết ong đốt, nhiều thầy thuốc đã sử dụng chất *Apis mellifica* được chế biến từ chính thân ong.

Nguyên tắc thứ hai của liệu pháp vi lượng đồng cân là giảm thiểu dần dần, từ từ liều thuốc đang sử dụng tới lượng cực nhỏ nhằm kích hoạt tác động tốt của thuốc, đồng thời lại hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của thuốc. Trong liệu pháp này, các chất thuốc đều được chế biến từ những hoạt tố có nhiều nguồn gốc (động vật, thực vật và khoáng vật) rồi qua nhiều lần hòa tan, khuấy động, cô đặc để tạo

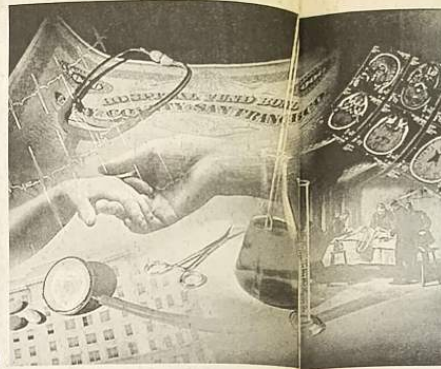


Hahneman.

thành những viên, dung dịch, hạt tròn kèm lactose hoặc saccharose. Có thể uống thuốc nhiều lần trong ngày hoặc đặt trong miệng, dưới lưỡi để thẩm thấu vào niêm mạc.

Liệu pháp vi lượng đồng cân được chỉ định trong những trường hợp nào?

Đó là những bệnh chức năng, nghĩa là bệnh sinh ra do vài bộ phận hoặc một tạng trong cơ thể có rối loạn hoạt động nhưng không có tổn thương thực thể. Thể liệu pháp này có thể chữa trị bách bệnh được



GS. TRẦN PHƯƠNG HẠNH

không? Câu trả lời rõ ràng và dứt khoát là không. Cách chữa trị này thường chỉ được áp dụng cho những bệnh do các nguyên nhân tâm lý (psychologic) hoặc tâm thể (psychosomatic), cho những trường hợp bệnh không còn cách điều trị nào khác hữu hiệu hơn (như phẫu thuật, sử dụng kháng sinh). Như vậy, liệu pháp vi lượng đồng cân có thể dùng để chữa trị những trường hợp rối loạn không nguy hiểm đến tính mạng như eczema, hen suyễn, chứng co giật, viêm đại tràng, mất ngủ, lo âu, nhức đầu, đau mỏi khớp. Ngược lại, những bệnh cấp tính (nhồi máu...), bệnh nặng (ung thư...), bệnh có tổn thương thực thể (tiểu đường...) cần được chữa trị theo y học hiện đại vốn đã đạt được rất nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. Một điều cần lưu ý là người bệnh không được tự ý ngừng cách chữa trị kinh điển hiện đại đang được chỉ định để chuyển sang liệu pháp vi lượng đồng cân nếu không có ý kiến của thầy thuốc đang điều trị. Hơn nữa, y học hiện đại luôn đòi hỏi phải xác định rõ chất liệu, dù cho nhỏ, giữ vai trò hoạt tác trong liệu pháp vi lượng đồng cân.

Khi thực hiện liệu pháp vi lượng đồng cân, thầy thuốc phải trao đổi

y kiến thật kỹ càng, tỷ mỉ với người bệnh nhằm phát hiện rồi đánh giá các dấu hiệu lâm sàng, khoảng thời gian và không gian xuất hiện bệnh, đáng về cũng như cách ứng xử của người bệnh, tâm tính (hướng ngả hoặc hướng ngoại, dễ nóng giận hoặc ủ rũ, ầu sầu), những điều người bệnh ước muốn cũng như cảm ghét, tóm lại là toàn bộ hoạt động chức năng của người bệnh. Liệu pháp vi lượng đồng cân không đòi hỏi một chẩn đoán thật chính xác, khoa học (theo cách hiểu của y học hiện đại) bởi vì chất thuốc dùng chữa trị sẽ được chọn lựa không phải cho một thể bệnh đặc hiệu mà cho một tổng thể các triệu chứng.

Chúng ta hãy trở lại với người thầy thuốc đã sáng tạo ra liệu pháp vi lượng đồng cân: Christian Friedrich Samuel Hahneman. Ông

sinh năm 1755 tại Meissen, vùng Saxe thuộc miền Đông nước Đức, theo học y khoa ở Leipzig và Dresden nhưng không thành đạt nên phải làm nghề dịch thuật để nuôi sống một gia đình quá đông con. Trong khi dịch (1789) tác phẩm "Chất liệu y học" của Cullen, ông nảy sinh những ý nghĩ đầu tiên về "tinh đồng dạng đồng cân" của một số chất thuốc. Lúc đó đang có cuộc tranh luận về việc sử dụng quinquina què mồm trong điều trị chứng sốt cao, vì vậy ông đã tiến hành thử nghiệm ngay trên bản thân và ghi chép những nhận xét riêng: Thuốc sẽ cắt cơn sốt ở người bệnh nhưng lại gây sốt ở người lành. Khi đang hành nghề ở Torgau (1790), ông đề xuất "Định luật đồng dạng", theo đó chức năng chữa bệnh của các loại thuốc phải dựa trên đặc điểm của chúng, nghĩa là các loại thuốc sẽ gây những triệu chứng giống hệt (đồng dạng) những triệu chứng của bệnh. Sau đó, ông viết cuốn "Nguyên cứu một nguyên tắc mới để điều trị bệnh" (Berlin, 1797) đặt nền tảng cho liệu pháp vi lượng đồng cân với nguyên lý "Chất đồng dạng chữa bệnh cùng dạng" nhằm chống lại việc sử dụng thuốc quá mức, đồng thời xác định rằng một chất càng ít tác động khi lượng chất đó càng nhỏ, vì vậy cần thiết phải pha loãng nó. Ông xuất bản cuốn "Nghệ thuật chữa khỏi bệnh" (Leipzig, 1810) nhằm đặt nền tảng cho liệu pháp mới. Luận thuyết của ông không được chấp nhận và cũng chẳng mấy ai chú ý, cho đến khi ông chữa khỏi bệnh cho một thiếu nữ trẻ người Paris rồi kết hôn với cô gái 18 tuổi này, lúc đó ông đã 40 tuổi. Gia đình ông chuyển đến ở Paris (1835), từ đó ông thành đạt và nổi danh khắp nước. Học trò và những người mến tài ông đã thành lập "Liên minh liệu pháp vi lượng đồng cân". Sau này, các thầy thuốc Đức nhớ tới người đồng hương đã tổ chức một bệnh viện thực hiện liệu pháp này ở Stuttgart, một thành phố ở miền Nam nước Đức (Ngày nay bệnh viện mang tên Robert Bosch và trở thành trung tâm truyền bá liệu pháp đó). Hahneman qua đời tại Paris lúc ông 88 tuổi (1843).

SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG VỚI BẠN ĐỌC

✎ Nguyễn Thị Liêm - Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định: **Chồng tôi là Nguyễn Văn Bằng, 32 tuổi. Cuối tháng 1/2003, chồng tôi phải vào cấp cứu tại BV. Chợt Ráy do có khối u trong não. Sau 2 tháng điều trị, bệnh thuyên giảm rất chậm dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng vẫn không lấy được khối u. BS cho biết chồng tôi bị u não ác tính phải điều trị bằng tia xạ trị với số lượng là 27 tia, mỗi tia 700.000 đồng, sau 5 tia đầu chụp CT-Scanner để theo dõi tiến triển.**

Trước đó, chồng tôi đã điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Định. Gia đình đã phải bán đi căn nhà ở quê được 16 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trang trải chi phí thuốc men... Nay, hoàn cảnh rất khó khăn nên vợ chồng tôi đang nằm ở trại 25 chờ bán tia xạ nếu có tiền.

Trong lúc quán bách, tôi chỉ biết nghĩ đến SK&DS. Mong SK&DS cho tôi một lời khuyên.

SK&DS hết sức thông cảm với trường hợp của vợ chồng chị. Theo tìm hiểu, SK&DS được biết đây cũng là nỗi khổ chung của nhiều bệnh nhân nghèo, mắc những căn bệnh có chỉ định xạ trị trong khi chi phí điều trị lại quá cao. BS. Trương Văn Việt, GD. BV. Chợ Rẫy cho biết: bệnh viện luôn luôn có chế độ chính sách miễn giảm viện phí cho những trường hợp bệnh nhân nghèo. Đặc biệt trong các trường hợp cần xạ trị. Theo đó, BV đã miễn giảm gần 47% tổng chi phí xạ trị của bệnh viện, tức trung bình hàng tháng, bệnh viện dành hơn 1 tỷ đồng cho khoản miễn giảm xạ trị. Như vậy, BV cũng đã rất nỗ lực cùng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của người bệnh và thân nhân.

Riêng trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Bằng, SK&DS rất mong có được sự hỗ trợ từ những tâm lòng hảo tâm của tất cả độc giả nhằm giúp anh Bằng sớm trở lại cuộc sống bình thường cùng vợ và 2 con còn nhỏ dại.

✎ Đặng Văn Chiến - kỹ thuật viên một công ty chế tạo khuôn nhựa, khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Chánh, TPHCM: **Được biết ngành y tế TPHCM luôn có hướng phát triển và hình thành những chuyên khoa sâu, phục vụ cho người dân trên địa bàn cũng như nhiều bệnh nhân ở các tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc cả hệ thống BV của TP chưa có một khoa phòng nào dành cho người lớn, theo SK&DS có phải là một vấn đề bức xúc?**

Tuy chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ phòng xạ ra hàng năm tại Việt Nam nhưng riêng ở TPHCM, được biết số lượng bệnh nhân phải đến điều trị tại các BV đang ngày một gia tăng. Việc xây dựng một chuyên khoa cho cả TP là vấn đề không đơn giản, nhất là khoa phòng, việc đầu tư không chỉ dừng lại ở chi phí mà còn là vấn đề con người và môi trường. Theo Sở Y tế TPHCM thì trong năm 2003, Sở đã lên kế hoạch xây dựng một khoa phòng tại BV. Nhân dân Gia Định. Hy vọng điều này sẽ sớm được thực hiện.

SK&DS

THỊ TRƯỜNG NẤM LINH CHI Ở VIỆT NAM - TRẦN ĐÓ BÁT QUẠI

Nấm linh chi trong các cửa hàng Đông dược

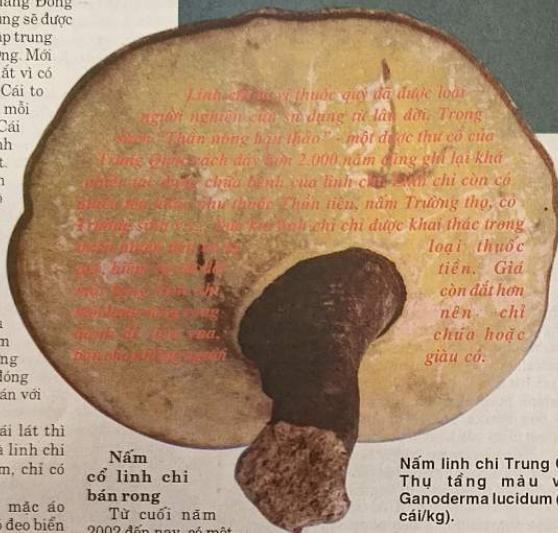
Vào bất kỳ một cửa hàng Đông dược nào ở Hà Nội, bạn cũng sẽ được chào mua nấm linh chi, tập trung nhiều nhất là ở phố Lãn Ông. Mỗi thoát nhìn, bạn sẽ lóa mắt vì có đủ loại linh chi to, nhỏ. Cái to nhất bằng cái nón nhỏ, mỗi túi 1kg có 2 hoặc 3 nấm. Cái nhỏ thì 15-20 cái/kg. Rồi linh chi thái lát, linh chi tán bột. Cũng cùng một thứ nấm linh chi có màu sắc, độ lớn, cân nặng như nhau, nhưng có của hàng giới thiệu là linh chi Hàn Quốc vì có chữ KOREA đóng dấu chìm ở mặt dưới nấm, được chào với giá 1.500.000d/kg. Sang các hàng khác, cùng cái nấm linh chi như thế (nhưng không có chữ KOREA đóng dấu chìm) lại được chào bán với giá 400.000d/kg.

Còn nấm linh chi thái lát thì của hàng nào cũng nói là linh chi Trung Quốc, giá rất mềm, chỉ có 200.000d/kg.

Tôi được một người mặc áo Blouse trắng, ở ngực áo có đeo biển "Bác sĩ chuyên khoa Đông y V.V.C." giới thiệu: "Bác cứ mua đi, ở đây chúng tôi chỉ bán linh chi của Hàn Quốc, chúng tôi sẽ xay thành bột cho bác, khi dùng chỉ việc sắc nước, sôi 15 phút là được". Tôi hỏi: "Thế bà linh chi có dùng được không?". Vì bác sĩ nó trả lời "Ai dùng bà làm gì, tất cả nó đã tan ra nước rồi!".

Vào cửa hàng bán lẻ thuốc Nam-Bác của Công ty Dược liệu TW I hỏi mua linh chi, cô bán hàng cho tôi xem cả 2 loại linh chi Hàn Quốc và Trung Quốc. Loại của Hàn Quốc mặt dưới (thụ tạng) nấm có màu trắng, đóng dấu chìm chữ KOREA. Giá bán 1kg loại 6 cái là 660.000d. Linh chi Trung Quốc mặt dưới nấm có màu vàng, giá 250.000d/kg (loại 6 cái 1kg).

Thực hư về nấm linh chi
DS. TRẦN XUÂN THUYẾT



Nấm cổ linh chi bán rong

Từ cuối năm 2002 đến nay, có một số người mang những mảnh nấm linh chi rất lớn, để trong túi du lịch len lỏi đến những nhà có người bệnh ung thư, tiểu đường, thoái hóa cột sống v.v..., nói là thuốc quý mới phát hiện trong rừng sâu Tây Nguyên đã được các nhà khoa học xác định là cổ linh chi có hàng trăm năm tuổi, chữa khỏi nhiều bệnh nan y ở thời kỳ cuối. Giá mỗi lạng (100g) từ 120-150.000d tùy loại nhỏ hoặc to. Để minh chứng cho lời giới thiệu của mình họ còn mang theo cả bản photocopy các bài viết nói về nấm cổ linh chi đăng trên báo Lao Động và báo Sức Khỏe & Đời Sống.

Xác định xuất xứ của nấm linh chi
Có người mang nấm linh chi đến

Nấm linh chi Trung Quốc. Thụ tạng màu vàng. Ganoderma lucidum (loại 4 cái/kg).

nhờ tôi phân biệt họ: Thứ nào của Trung Quốc, thứ nào của Hàn Quốc? Tôi trả lời: Chúng tôi chỉ có thể phân biệt được cổ linh chi và linh chi trắng. Còn thứ nào trông ở Trung Quốc, thứ nào trông ở Hàn Quốc thì kể cả người chuyên nghiên cứu, phân loại thực vật hoặc chuyên kiểm nghiệm dược liệu cũng chịu, vì linh chi được trồng ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc v.v... không phải chỉ có một loài. Trong khi chỉ riêng một loài Ganoderma lucidum thôi cũng đã có hơn 45 thứ khác nhau. Còn việc đóng dấu chìm chữ KOREA trên nấm để nói đó là của Hàn Quốc thì có gì khó.

NẤM LINH CHI TRONG THIÊN NHIÊN

Linh chi (Ganoderma) là các loài



Nấm linh chi Hàn Quốc. Thụ tạng màu trắng. Ganoderma lucidum (Loại 6 cái/kg). Ảnh: Trần Xuân Thuyết.

nấm gỗ mọc hoang trong thiên nhiên, có hàng trăm loài khác nhau cùng họ nấm gỗ (ganodermataceae). Có 2 nhóm lớn là: Cổ linh chi và linh chi.

Cổ linh chi: Là các loài nấm gỗ không cuống (hoặc cuống rất ngắn) có nhiều tầng (mỗi nấm thụ tạng lại phát triển thêm một lớp mới chồng lên). Mũ nấm hình quạt, màu từ nâu xám đến đen sẫm, mặt trên sù sì thô ráp. Nấm rất cứng (cứng như gỗ lim nên còn gọi là nấm lim).

Chúng sống ký sinh và hoại sinh trên cây gỗ trong nhiều năm (đến khi cây chết thì nấm cũng chết). Vì vậy các nhà bảo vệ thực vật xếp cổ linh chi vào nhóm các tác nhân gây hại cây rừng, cần không chế. Cổ linh chi mọc hoang từ đồng bằng đến miền núi ở khắp nơi trên thế giới. Trong rừng rậm, độ ẩm cao, cây to thì nấm phát triển mạnh, tán lớn. Ở Việt Nam đã phát hiện trong rừng sâu Tây Nguyên có những cây nấm cổ linh chi lớn, có cây tán rộng tới hơn 1 mét, nặng hơn 40kg.

Tên khoa học: Ganoderma applanatum (Pers) Past. Cổ linh chi có hàng chục loài khác nhau.

Linh chi: Là các loài nấm gỗ mọc hoang ở những vùng núi cao và lạnh ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Quảng Đông (Trung Quốc). Nấm có cuống, cuống nấm có màu (mỗi loài có một màu riêng như nâu, đỏ vàng, đỏ cam). Thụ tạng màu trắng ngà hoặc màu vàng. Mũ nấm có nhiều hình dạng, phổ biến là hình thận, hình tròn. Mặt trên bóng. Nấm hơi cứng và dai.

Tên khoa học: Ganoderma lucidum (Leyss ex Fr) Kart (Linh chi có rất nhiều loài khác nhau). Sách *Bản thảo cương mục* (in năm 1595) của Lý Thời Trân, đại danh y Trung Quốc đã phân loại linh chi theo màu sắc thành 6 loại, mỗi loại có công dụng chữa bệnh khác nhau:

- Loại có màu vàng gọi là Hoàng chi hoặc Kim chi.
- Loại có màu xanh gọi là Thanh chi.
- Loại có màu hồng, màu đỏ gọi là Hồng chi hay Đơn chi hoặc Xích chi.
- Loại có màu trắng gọi là Bạch chi hay Ngọc chi.
- Loại có màu đen gọi là Huyền chi hay Hắc chi.
- Loại có màu tím gọi là Tử chi.

KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU NẤM LINH CHI

(Xem tiếp kỳ sau)

□ DIỄN ĐÀN CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ HÀNH ĐỘNG HỘI CHỨNG HỒ HẤP CẤP TRÂM TRỌNG (SARS).

Được tổ chức tại ĐHYD TPHCM vào sáng thứ bảy 12/04/2003 nhằm chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm của bệnh SARS tại Việt Nam và trên thế giới.

Hiện tại dịch SARS đã lan tràn đến 17 nước trên thế giới với 2.890 trường hợp nhiễm bệnh, số ca tử vong là 117. Tại VN, tổng số bệnh nhân bị nhiễm bệnh là 68, tử vong 5 (trường hợp tử vong mới nhất là một bác sĩ người Pháp gốc Việt tên Nguyễn Hữu Bội, một trong những trường hợp đầu tiên bị nhiễm bệnh).

Hội thảo đã trình bày những báo cáo mang tính thực tiễn của các GS, TS, BS từ Hà Nội (qua trực tuyến) và của nhà trường về tình hình dịch tễ, chẩn đoán, điều trị và vi sinh học của SARS. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS. Trần Thị Trung Chiến đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động tìm tòi và thực hiện các biện pháp phòng chống SARS của ngành y tế TPHCM.

PNK

□ AN GIANG: KHẨN TRƯỞNG PHÒNG CHỐNG DỊCH SARS

Là một trong những tỉnh trọng điểm, với 2 cửa khẩu biên giới với Campuchia, An Giang có nguy cơ bị lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) rất cao. Vì thế, sáng 5/4/2003, UBND tỉnh An Giang đã triệu tập cuộc họp thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch khẩn cấp; Chỉ đạo các ban ngành phối hợp cùng ngành y tế triển khai công tác phòng chống dịch. Với mục tiêu chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong, Sở Y tế đã thành lập ngay Ban đặc nhiệm với 4 tiểu ban. Kiểm dịch y tế, Dự phòng, Điều trị và Hậu cần để có thể thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh. Được biết, ngoài việc phát tờ rơi, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về dịch bệnh, Sở còn cho xây dựng ngay các phòng cách ly ở các cửa khẩu, 2 BV lớn của tỉnh cũng có phòng điều trị cách ly, trang bị thêm 2 xe cấp cứu đặc dụng, 4.000 khẩu trang đặc biệt, 200 bộ quần áo giấy sử dụng 1 lần, các trang thiết bị cần thiết.... UBND tỉnh cũng giao Công an và Hải quan quản lý chất khảm để người qua lại biên giới không qua trạm trên suốt tuyến biên giới dài gần 100 km.

NGUYỄN THANH HUỆ

bệnh nhân sang phòng khác, một số cho ra viện. Chúng tôi giải phòng 2/3 phòng bệnh, lấy cơ sở tiếp đón bệnh nhân vì dự kiến dịch có thể bùng lên rất lớn. Ngày 12/3 chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên là người phục vụ bệnh nhân Johnny Cheng ở khách sạn. Hôm sau 13/3: 5 bệnh nhân tiếp theo được chuyển đến. Ngày 14/3 thêm 11 bệnh nhân... Lượng bệnh nhân cứ thế đông dần lên, đến là những người đến sinh hoạt mổ ở BV. Việt - Pháp



Cùng GS. Lê Đăng Hà (người đứng bên phải) đang xem kết quả chụp phim phổi.

ĐÓI MẶT VỚI SARS

BS. Nguyễn Hồng Hà đón tôi với nụ cười thật hiền hậu và câu chuyện được bắt đầu: Hôm đó là thứ 7, đúng vào ngày 8/3, tôi nhận được điện từ BV. Quốc tế Việt - Pháp mời sang hội chẩn vì có 15 bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, gai rét, nhức đầu và đều bị tổn thương phổi nặng, một số xuất hiện tức ngực, khó thở, tiêu chảy. Lúc đó bệnh viện nghi ngờ về một bệnh dịch, có khả năng là bệnh cúm từ Hồng Kông lây sang. Tôi đi xuất với BV. Việt - Pháp phải thông báo ngay tình hình cho Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) Hà Nội. Sáng chủ nhật, Bộ Y tế triển khai họp chỉ đạo khoanh vùng; BV. Quốc tế Việt - Pháp phụ trách điều trị những nhân viên trong bệnh viện nhiễm bệnh, Viện YHLS các bệnh nhiệt đới nhận những bệnh nhân mắc bệnh và giao cho phòng cấp cứu triển khai phòng bệnh, chuyển hết

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hồng Hà là Trưởng phòng Cấp cứu Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới - đơn vị tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên mắc căn bệnh SARS từ Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp chuyển đến. Anh cũng là người thấy thuốc được coi là tiên phong trong đợt vật lộn với căn bệnh cực kỳ nguy hiểm này. Có người cảnh báo với tôi rằng: Anh có thể đã là một trong những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh. Thế nhưng...

trong thời gian có bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh hoặc là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân lúc đó. Số bệnh nhân mắc bệnh SARS điều trị tại phòng cấp cứu đến thời điểm này là 24 người, của cả Viện (trừ những trường hợp nghi ngờ) là 43

bệnh nhân (những bệnh nhân qua giai đoạn bệnh kịch phát có xu hướng giảm hoặc khỏi bệnh được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng khác để theo dõi đúng quy chuẩn: sau khi hết sốt 5 ngày phải giữ lại 7 ngày). Lúc này, mọi người đều đã biết thông tin về một vụ dịch bùng phát và chúng tôi có 2 nhiệm vụ chính là hạn chế tối đa mức độ tử vong và phòng tránh lây lan cho nhân viên.

Làm công tác dịch tễ bao năm,



MAI LINH

Giây phút thư giãn hiếm hoi sau những giờ làm việc.

chúng tôi đã phải đối mặt với những vụ dịch lớn, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng với dịch viêm đường hô hấp cấp, khả năng phòng vệ rất khó, mức độ lây nhiễm đối với nhân viên y tế rất lớn, WHO đã cảnh báo về nguy cơ tử vong khi có những thông tin ban đầu về dịch bệnh từ Hồng Kông lan tới. Tôi hỏi anh: - Là người đầu tiên sau các bác sĩ ở BV. Việt - Pháp tiếp xúc với bệnh SARS, trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy, anh có nghĩ đến khả năng mình sẽ bị nhiễm bệnh? BS. Hà mỉm cười, vẫn nụ cười nhẹ nhàng và rất hiền: Tôi có nghĩ đến khả năng đó chứ. Nhưng đây là

nhiệm vụ của mình, không thể thoái thác. Nếu thấy mình có biểu hiện hơi sốt tôi sẽ vào Viện ngay lập tức. Tôi tiếp xúc với bệnh từ ngày 8/3, đến nay đã gần 1 tháng. Tôi nghĩ thời gian ủ bệnh trong khoảng 10 ngày, nếu bị lây chủ yếu là trong những ngày đầu. Giờ chắc mình không nhiễm bệnh được nữa vì khả năng miễn dịch tốt. Tôi bắt cười trước niềm lạc quan của anh. Câu chuyện lại tiếp tục về công việc của anh và các đồng nghiệp, dường như anh thích nói về họ hơn.

CHỐNG CHỊ VỚI DỊCH BỆNH

Xác định mức độ nguy hiểm của bệnh dịch, mọi người đều sẵn sàng,

nội bào. Chúng tôi sử dụng các thuốc Quinolone thế hệ mới 1 viên/ngày + Doxycycline 2 viên/ngày hoặc dùng Doxycycline kết hợp với Zithromax 2 viên/ngày. Theo dõi sát chức năng hô hấp, độ bão hòa oxy. Với bệnh nhân suy hô hấp: cho thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ 12 lít/phút. Nếu chưa đưa được độ bão hòa oxy lên thì cho thở máy không xâm nhập (thở qua một dụng cụ đặt vào miệng, không can thiệp vào đường hô hấp). Biện pháp này rất quan trọng, giảm được nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn bệnh viện. Với bệnh nhân nặng thì dùng thêm Solumedrol 2-3 lít/ngày để giảm viêm phù và đầy



BS. Hà (người bên phải) đang trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân mắc bệnh SARS.

là tổn thương phù nề. Diễn hình là trường hợp chị Đ. T. H. (đến sinh ở BV. Việt - Pháp) điều trị trong Viện từ ngày 13/3 đến giờ. Mấy ngày đầu phải kê gối ngồi ôm mặt nạ thở cả ngày lẫn đêm (nếu nằm xuống thì độ bão hòa oxy hạ, có lúc đo chỉ có 37mmHg (người bình thường 80-90mmHg)). Nay chị H. đã khỏi bệnh nhưng vẫn được giữ lại Viện theo dõi. Một số bệnh nhân khác chậm nhịp tim (dưới 50 lần/phút) không đủ cung cấp oxy cho não rất nguy hiểm. Như bệnh nhân V. T. N. 27 tuổi bị chậm nhịp tim, suy gan, tổn thương nặng 2 phổi, bệnh cảnh trầm trọng. Điều đặc biệt là bệnh nhân này không có yếu tố dịch tễ, chỉ ăn trứng vịt lộn ở cổng BV. Việt Pháp. Hay bệnh nhân V. K. K. 76 tuổi (mắc bệnh khi vào BV. Việt - Pháp mổ tắc ruột do dính dây chằng) lại kèm theo cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - COPD rất nặng, ngoài dùng thuốc làm tăng nhịp tim, phải cho dùng các thuốc giãn phế quản. Chúng tôi phải

mượn thêm máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể để dùng cho bệnh nhân. Tình trạng các bệnh nhân tiến triển tốt, hiện chỉ còn 5 người đang điều trị đặc biệt tại phòng cấp cứu (trong đó có 2 người do BV. Việt - Pháp mới chuyển tới), 13 bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn đã ra viện, số khác đang tiếp tục được theo dõi. *Nếu mặt giận ra, BS Hà không giấu niềm vui và tự hào:* Sau hơn nửa tháng chống chọi với dịch, các chuyên gia của WHO rất ngạc nhiên khi thấy ở đây chưa có trường hợp lây bệnh sang nhân viên y tế hoặc người nhà bệnh nhân. Về mặt dịch tễ học, tôi nghĩ mỗi trường hợp lấy ở BV. Việt - Pháp là do của

luôn đóng kín và sử dụng máy điều hòa. Do đó chúng tôi tạo bầu không khí thông thoáng bằng cách mở cửa, thông gió để đẩy mầm bệnh ra ngoài (virus ra ngoài sẽ bị ánh sáng tiêu diệt), không để virus quanh quẩn trong phòng. Chúng tôi còn áp dụng phương pháp dân gian đốt những quả bồ kết cho khói xông dọc hành lang, ngày nào cũng đốt vài lần. Đến giờ mọi người đã yên tâm, bớt lo lắng phần nào nhưng vẫn phải phòng hộ nghiêm ngặt, thực hiện sát trùng khô, thay quần áo trước và sau khi ra về. Tự bản thân tôi cũng tránh tiếp xúc, quan hệ nhiều. Ban bè chủ yếu thăm hỏi chia sẻ qua điện thoại.

Chưa bao giờ hình ảnh so sánh về người thầy thuốc như những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống bệnh tật lại cụ thể, rõ ràng và chân thực trong tôi đến như vậy. Biết bao người trong số họ đã lảng lẽ hy sinh! Một sự hy sinh không đòi hỏi đến đáp. *Bác sĩ Hà nói thêm:* "Chúng tôi được hưởng chế độ bồi dưỡng cho nhân viên y tế phòng chống dịch là 24.000 đồng/người/ngày. Được biết Chính phủ sẽ tăng lên gấp 5 lần. Tôi thấy đó là sự quan tâm của Nhà nước đối với người cán bộ y tế. Để thực hiện cần phải có thời gian". Tôi cũng nghĩ mình đã được dân phải phòng bị thế nào để tránh tối đa nguy cơ nhiễm bệnh; nhưng trong hơn 2 giờ ngồi nói chuyện với anh, tôi không biết mình đã bỏ khẩu trang tự bao giờ. ■

1. Nhức đầu là gì?

Nhức đầu là có triệu chứng đau ở vùng đầu, đây là một kinh nghiệm phức tạp, không chỉ là sự khó chịu về mặt cảm giác mà còn liên quan đến vấn đề tinh cảm, tâm lý. Theo số liệu thống kê ở các phòng khám, ước tính có đến một nửa bệnh nhân đến gặp bác sĩ vì bị nhức đầu.

2. Những yếu tố nguyên nhân nào gây nhức đầu?

Nhức đầu là triệu chứng của rất nhiều nguyên nhân. Có thể kể một số nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân nội sọ: Như bị u não, viêm màng não, co giãn mạch máu đưa đến nhức nửa đầu.

- Nguyên nhân tại chỗ: Tai - mũi - họng (viêm các xoang), răng hàm mất (sâu răng, lệch khớp cắn), mắt (rối loạn khúc xạ như bị cận thị, viễn thị), xương khớp (thoái hóa cột sống cổ).

- Nguyên nhân toàn thân: Gồm rất nhiều bệnh nội khoa, thậm chí do tăng huyết áp hoặc bị táo bón.

- Nguyên nhân nhiễm trùng (cúm, viêm phổi, sốt rét...) hoặc ngộ độc (ngộ độc rượu, ngộ độc thuốc).

Ngoài ra còn do nguyên nhân tâm lý (làm việc quá căng thẳng) hay có loại nhức đầu không xếp loại được.

3. Khi nào bệnh nhân nên đi bệnh viện hoặc khám bác sĩ?

Bệnh nhân nên đi bệnh viện hoặc khám bác sĩ khi có những triệu chứng sau:

- Nhức đầu kéo dài: Dùng thuốc giảm đau có cải thiện nhưng sau đó đau lại tái phát và kéo dài.

- Nhức đầu bộc phát và dữ dội: Người đang khỏe mạnh, đột nhiên nhức đầu dữ dội, có thể kèm theo ói mửa.

- Nhức đầu âm ỉ kéo dài và sau đó xuất hiện triệu chứng rối loạn tâm thần.

Nếu có một trong các triệu chứng trên, người bệnh cần đến khám bác sĩ vì chẩn đoán nguyên nhân nhức đầu có khi đòi hỏi kiến thức chuyên môn rộng của nhiều chuyên khoa và nhiều loại xét nghiệm.

Dùng thuốc trị nhức đầu

4. Thuốc nào có thể tự sử dụng để điều trị nhức đầu?

Nên lưu ý, để trị nhức đầu chủ yếu phải điều trị nguyên nhân (phần này thuộc bác sĩ chuyên khoa). Riêng người bệnh có thể tự sử dụng thuốc giảm đau để trị triệu chứng và chỉ nên dùng thuốc giảm đau bậc 1 được đề xuất bởi Tổ chức Y tế Thế giới. Tức là có thể tự dùng một số thuốc như Paracetamol (còn có tên Acetaminophen), Aspirin hoặc một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) để điều trị. Nên chọn Paracetamol vì thuốc khá an toàn. Đặc biệt, những người thuộc loại yếu dạ dày, bị hen suyễn hay có vấn đề về tim mạch không nên dùng Aspirin hay NSAID.

TS. DS. NGUYỄN HỮU ĐỨC

(Trường ĐH. Y Dược - TP HCM)

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, nhu cầu làm đẹp cũng không ngừng tăng lên, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến thể dục thẩm mỹ... Trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở, trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy "làm đẹp cho răng" bao gồm những vấn đề gì?

Nha khoa thẩm mỹ trong cuộc sống hiện đại

BS. VÕ DUY HUY

(Trung Tâm Nha khoa Nụ cười - TP HCM)

Ngành nha khoa hiện đại không chỉ điều trị những bệnh về răng, đem đến cho bệnh nhân răng tốt mà còn góp phần quan trọng vào đáng thẩm mỹ cho răng.

Chỉnh nha:

Bác sĩ chuyên khoa về chỉnh hình có thể sắp xếp lại những răng mọc cho ngay hàng thẳng lối, điều này rất cần vì răng mọc khấp khiêng (Người hay đùa gọi là hàm răng 9-6-3-0) không chỉ thiếu thẩm mỹ mà còn rất khó giữ vệ sinh, dễ bị sâu răng, nha chu...

Trước đây chỉnh nha chỉ có thể thực hiện cho trẻ em vì xương còn mềm, nhưng ngày nay với các kỹ thuật chỉnh hình cố định, lứa tuổi có thể chỉnh nha được mở rộng hơn. Điều cần lưu ý là bệnh nhân phải chọn đúng bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình (Số lượng bác sĩ chỉnh hình ở Việt Nam hiện nay không nhiều) và phải kiên trì (Một ca chỉnh hình có thể kéo dài vài năm).

Thay đổi màu răng:

Nếu chẳng may có một màu răng quá sậm, bạn có thể nhờ bác sĩ làm cho màu răng của bạn trắng đẹp hơn. Bác sĩ sẽ lấy khuôn răng để làm một máng nhựa vừa vặn với hàm răng, máng này dùng đựng thuốc tẩy răng.

Bệnh nhân sẽ mang máng có thuốc tẩy răng ở nhà từ 1-3 giờ trong 1-2 tuần (đối với ca sậm màu trung bình).

Cần chú ý phân biệt tẩy trắng với làm vệ sinh (Clean răng). Tẩy trắng làm thay đổi thật sự màu răng còn làm vệ sinh răng là đánh sạch những vết dơ dính ở mặt ngoài răng nên trông răng có vẻ sáng hơn tuy màu răng không thay đổi.

tiền thẩm mỹ không chỉ trong điều kiện ánh sáng tự nhiên mà còn với những nguồn sáng nhân tạo (Như ánh đèn sân khấu, ánh đèn tím back light). Răng giả phải trông giống hệt như răng thật (Những chất liệu răng giả trước đây có độ phản quang khác với răng thật nên sẽ phát sáng hoặc biến mất dưới ánh đèn tím).

Có thể chia làm hai loại răng giả: Loại lắp dính (răng giả cố định)



Hệ thống X-quang kỹ thuật số phục vụ nha khoa.

Trám răng thẩm mỹ:

Gọi là trám răng thẩm mỹ vì vật liệu trám ngày nay cùng màu với răng trám, không chỉ giúp phục hồi lại hình dáng, chức năng nhai mà còn trả lại cho răng màu sắc tự nhiên như cũ, thậm chí có thể che lấp những khuyết điểm của men răng (như men răng bị vỡ, đổi màu...).

Vật liệu trám răng phổ biến hiện nay là composite quang tổng hợp, chỉ đông cứng khi soi đèn Halogen và được dán vào răng bằng keo dán nha khoa.

Lắp đặt răng giả thẩm mỹ và tiện lợi:

Sự tiến bộ về kỹ thuật, thiết bị và chất liệu đã giúp ngành nha khoa hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân vì lý do nào đó phải làm răng giả.

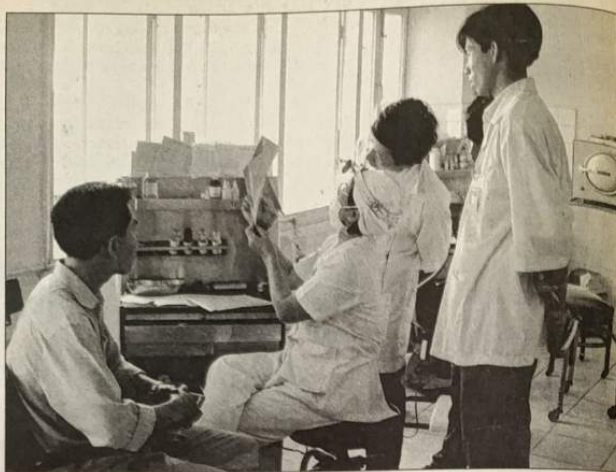
Người bệnh ngày nay đòi hỏi răng giả không chỉ nhai tốt mà còn phải đẹp; Không chỉ tiện dụng, bền chắc mà còn tạo cảm giác như răng thật cho người sử dụng. Bảo đảm

và loại tháo lắp. Loại lắp dính được bệnh nhân ưa chuộng hơn vì tiện lợi, sức nhai phục hồi tốt hơn loại tháo lắp, dĩ nhiên là có giá thành cao hơn.

Tuy nhiên không thể khẳng định loại nào tốt hơn vì tùy trường hợp mất răng, bác sĩ sẽ tham vấn cho bạn loại lắp dính hay tháo lắp. Loại lắp dính thường được dùng khi mất ít răng, còn loại tháo lắp thường được dùng khi mất nhiều răng.

Về chất liệu làm răng thì trước đây chỉ có nhựa (Resin) để làm răng, lợi giả và kim loại để làm phần khung sườn. Ngày nay còn có thêm composite, sứ để làm răng giả rất thẩm mỹ. Phần khung sườn ngoài quý kim còn có thể làm bằng sợi thủy tinh và sứ không kim loại.

Do giá biểu làm răng tại các nước phát triển tương đối cao nên hiện nay ở nước ta, các trung tâm nha khoa thẩm mỹ ngoài việc đáp ứng nhu cầu điều trị trong nước còn có thêm khá nhiều các bệnh nhân Việt kiều. ■



TỪ PHÒNG KHÁM đến NHÀ THUỐC

TỪ PHÒNG KHÁM...

Mỗi khi chúng ta mắc bệnh, nếu dùng thuốc tại nhà vài ngày không đỡ, tốt nhất nên đến phòng khám để bác sĩ xác định hướng điều trị. Thường thấy thuốc sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe, tình trạng bệnh tật, thị trường thuốc và khả năng kinh tế của người bệnh để chỉ định cách điều trị và dùng các loại thuốc sao cho hiệu quả nhất. Nhưng thực tế lại không luôn như thế!

Tôi đã thấy có bệnh nhân cầu gât: đi 3,4 buổi chỉ được vài viên thuốc cảm và B1 nội rẽ tiền. Nếu ai cũng nghĩ như thế thì thuốc của các xí nghiệp trong nước sản xuất sẽ tiêu thụ cho ai? Chúng ta cần biết tất cả các thuốc dù dù nhỏ,

đắt tiền hay rẽ tiền đều được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn mới xuất xưởng. Thật là nghịch lý, trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều người lại bỏ tiền ra mua các loại thuốc ngoại cùng tác dụng nhưng đắt gấp 3, 4 lần, thậm chí 10 lần thuốc nội. Có người mới thấy hơi mệt (tuy chưa đến mức truyền dịch) nhưng cũng cố chạy vay để được truyền đạm hay nước biển và xem đấy như một bảo bối, một thần dược để điều trị. Người có điều kiện kinh tế đã vậy còn người nghèo cũng cố vay mượn, xoay sở để có tiền được truyền. Không những truyền ở bệnh viện, bệnh xá mà còn truyền ở nhà trong môi trường không đảm bảo vệ sinh, không có bác sĩ chỉ định; Có

y tá thì truyền, cấm kim xong để đấy rồi đi làm việc khác và biết bao tai biến đã xảy ra cho bệnh nhân. Thuốc bổ của ta cũng ít được chuộng, thường người ta thích dùng thuốc ngoại hơn, như Fortex điều trị gan, 3B ngoại..., cầu cạnh bác sĩ cho bằng được thuốc ngoại đắt gấp chục lần thuốc nội.

Nhiều thấy thuốc chưa biết được dạng thuốc, hàm lượng biệt được chỉ mới qua một khóa trình được viên nhưng luôn tìm cách thuyết phục bệnh nhân chọn dùng thuốc ngoại. Rồi không ít bệnh nhân lại muốn khám dịch vụ để nhanh chóng và được nhiều thuốc ngoại hơn khám bảo hiểm.

DS. LÀ XUÂN HOÀN

ĐẾN NHỮNG CHUYỆN Ở NHÀ THUỐC

Thuốc dùng muốn có hiệu quả phải theo đúng chỉ định của bác sĩ về cách dùng, thời gian dùng và liều dùng. Có người đã uống tăng liều gấp đôi để mong chóng khỏi bệnh. Ngược lại có người mới uống 1 ngày thuốc thấy đỡ nên ngưng không uống nữa. Có bệnh nhân đang nằm viện lại ra ngoài mua thêm thuốc bổ (vitamin B12) nhờ tiêm hồ. Điều này rất nguy hiểm vì có thể gây phản ứng thuốc, ảnh hưởng đến việc điều trị (ví dụ bệnh ung thư không được dùng vitamin B12...). Vì vậy khi bán thuốc, dược sĩ phải xem lại đơn, thay thế các loại thuốc cùng tác dụng, khác hàm lượng để bán đúng liều bác sĩ cho hay giới thiệu với bệnh nhân những loại thuốc Bộ Y tế đã cấm lưu hành như Levamisol, Danzen... Đó là những việc làm cần thiết để việc dùng thuốc được an toàn, hợp lý.

Đã có trường hợp bệnh nhân muốn mua Mofen nhưng lại nói nhầm là Morphin (chất độc bằng A gây nghiện); Hoặc nhầm ngày sản xuất (ví dụ SX 1/2002) sang thời gian hết hạn dùng (Có nhà sản xuất ghi rõ *Hạn dùng (HD): ngày, tháng, năm*, nhưng cũng có nơi chỉ ghi ngày sản xuất, HD 24 tháng, người mua tự kiểm tra lấy để biết còn hạn hay không?).

Prednisolon không phải là thần dược, bệnh nào cũng dùng được mà phải do bác sĩ chỉ định. Nếu lạm dụng sẽ gây nhiều tác hại, thậm chí rất nghiêm trọng. Việc thay đổi màu của xi nghiệp đôi khi cũng làm người bệnh nghi ngại; Ampicillin trước có hai màu đỏ trắng nay đổi lại màu gạch cua, trắng; Amoxycilin trước đỏ vàng nay đỏ trắng... Bơm tiêm diệt trùng đem về nhà xé ra dùng thấy không hợp quay lại nhà thuốc để nghị đổi. Mua dung dịch ASA trong không màu tại nhà thuốc cứ thắc mắc sao hôm trước mua ở trạm xá màu vàng, vì nghĩ rằng dung dịch màu vàng đặc hơn loại trong mà không hề biết màu vàng là do thuốc đã bị oxy hóa)...

Đặc biệt cần thận trọng với các

VĂN BẢN

Ngày 3/4/2003, Cục Quản lý Dược Việt Nam ra công văn số 2134/QLD-ĐK thông báo:

Cục Quản lý Dược Việt Nam nhận được công văn số 312/2003/TB-SHCN ngày 17/03/2003 của Cục Sở hữu công nghiệp về việc: "Thông báo về địa chỉ CSDL NHHH trên mạng Internet" nhằm cung cấp thông tin kịp thời về các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam theo thể thức nộp đơn quốc gia, phục vụ cho các nhu cầu nghiên cứu để thiết kế nhãn hiệu mới, theo dõi tình trạng pháp lý liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Địa chỉ trên mạng Internet như sau:

<http://ipdl.noip.gov.vn>

Cơ sở dữ liệu này bao gồm tất cả các nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký NHHH) và đã được công bố trên công báo SHCN. Các dữ liệu này thường xuyên được cập nhật ngay sau khi dữ liệu được công bố trên công báo SHCN.

Cục Quản lý Dược Việt Nam thông báo các Sở Y tế và các doanh nghiệp biết để khai thác, sử dụng.

loại thuốc cho trẻ em. Nhiều loại thuốc không đóng gói riêng cho trẻ mà dùng thuốc người lớn chia thành từng liều nhỏ. Đó là điều cần khắc phục, chẳng hạn: Trẻ em dưới 7 tuổi không được uống Tetracyclin. Nhiều loại thuốc không được dùng đối với trẻ đang bú mẹ. Nếu mẹ uống thuốc phải tạm ngưng cho con bú. Thuốc dùng cho trẻ em nên chọn dạng thích hợp để uống như xi-rô... Khi bị sốt, nếu không uống được thuốc nên thì dùng loại thuốc dạng.

Nếu cùng lúc dùng tất cả các dạng thuốc trị sốt thì phải cộng tổng liều các dạng thuốc (như thuốc cảm, viên nang, viên nén, viên sủi, thuốc đạn...) để tránh dùng quá liều. Thuốc không phải là kẹo nên cha mẹ không thể chiều các cháu, hề đến nhà thuốc là đòi mua cả lọ C về ngâm và phân phát cho các bạn. Chính vì thế nên tất cả các loại thuốc đều có ghi dòng chữ "Để xa tầm tay trẻ em".

Nhà thuốc là nơi giao tiếp có văn hóa, người bệnh thường tìm thấy ở đây những lời tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe và các loại

thuốc chữa bệnh. Thế nhưng cũng có kẻ thừa lúc người bán vô ý, khách đóng đã nhanh tay "chôm" thuốc.

Có thủ đoạn hai người rủ nhau đến nhà thuốc mua bơm tiêm và ống B1 tự tiêm lấy, xong 1 người giả vờ ngắt ngã lảo ra của hàng, đòi bắt đền vì thuốc "dòm"... Văn vắn và văn vắn...

Xem ra như thế việc khám bệnh, kê đơn, bán thuốc để chữa bệnh cũng có nhiều phức tạp. Thấy thuốc và dược sĩ phải luôn luôn học tập, nâng cao trình độ để chăm sóc người bệnh ngày một tốt hơn; Còn bệnh nhân cần thông cảm, theo đúng chỉ định của thầy thuốc, hướng dẫn của dược sĩ để việc điều trị được an toàn, hợp lý và có hiệu quả.



THÔNG TIN Y HỌC NƯỚC NGOÀI

□ THUỐC LÁ LÀM TĂNG NGUY CƠ Ở NGƯỜI XƠ HÓA HỆ THỐNG



Bệnh xơ hóa hệ thống sẽ gây biến chứng mạch máu ở ngoại vi, biến chứng mạch máu (động mạch) chủ yếu ở đầu ngón tay, chân sẽ làm thiếu máu nuôi và hoại tử đầu ngón. Một người bình thường nếu hút thuốc lá lâu năm cũng có thể xảy ra biến chứng ở động mạch ngoại biên và gây hoại tử. Điều trị hoại tử đầu ngón rất khó khăn, phải dùng thuốc giãn động mạch, nếu vẫn không hiệu quả thì phải cắt bỏ. Do đó khi bệnh nhân bị xơ hóa hệ thống nếu hút thuốc lá thì biến chứng mạch máu sẽ dễ xảy ra hơn. Suy luận này được làm sáng tỏ qua một nghiên cứu trên 101 bệnh nhân xơ hóa hệ thống (có 87 nữ), tuổi trung bình là 53 và đã bị xơ hóa hệ thống trung bình 13 năm. 21 bệnh nhân đang có hút thuốc lá, 37 bệnh nhân đã từng hút thuốc và 43 bệnh nhân chưa bao giờ hút thuốc. Kết quả có ý nghĩa thống kê (sau khi loại trừ các yếu tố tuổi tác, giới tính, thời gian mắc bệnh) cho thấy bệnh nhân xơ hóa hệ thống hút thuốc lá dễ bị biến chứng hoại tử đầu chi gấp 3 - 4 lần so với những người chưa bao giờ hút thuốc. Đặc biệt, những bệnh nhân hút thuốc nhiều dễ phải vào viện do biến chứng này.

(Theo *Journal of General and Internal Medicine*, 04/2003)

□ CUGBP2 CÓ THỂ LÀM TẾ BẢO UNG THƯ TỰ PHÁ HỦY

Ung thư là bệnh lý tạo thành do sự tăng sinh quá mức của các tế bào trong cơ thể. Một tế bào

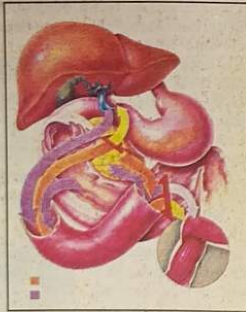
bình thường có chu kỳ sinh và rồi già đi, sau đó tự tiêu hủy, còn tế bào ung thư thì ngược lại, chúng luôn luôn "trẻ" và nhân lên mãi cho đến khi người bệnh tử vong. Các nhà khoa học vừa tìm ra một loại protein có khả năng làm tế bào ung thư tự phá hủy, được gọi là CUGBP2. CUGBP2 có nhiều chức năng và chúng liên kết cytidin-uridin-guanosin. Một tế bào bình thường luôn chứa đầy CUGBP2, protein này giúp tế bào chết đi bằng cách hoạt hóa chương trình tự phá hủy của tế bào. Nhưng tế bào ung thư thì không có CUGBP2 nên không chết được. Khi đưa Protein CUGBP2 vào tế bào ung thư sẽ làm hơn 70% tế bào bị chết. Phát hiện mới này hứa hẹn cho ra đời một phương thức điều trị ung thư hiệu quả hơn trong tương lai, ít ra cũng có thể giết chết một số tế bào ung thư để ngăn không cho bệnh tiến triển.

(Theo *Nature Biology*, 04/2003)

□ BỆNH NHÂN GHEP GAN ÍT BỊ BIẾN CHỨNG TIM MẠCH

Ở tất cả các bệnh nhân ghép tạng, đòi hỏi đều phải dùng thuốc ức chế thải ghép. Việc dùng các thuốc này sẽ làm tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch như: tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tăng homocystein.... Ghép gan là phương pháp hiệu quả nhất đối với bệnh nhân bị bệnh gan giai đoạn cuối (viêm gan siêu vi, xơ gan, các bệnh gan mãn tính...).

Các nhà khoa học đã theo dõi trong thời gian dài 116 bệnh nhân sau ghép gan, kết quả cho thấy 5



năm sau ghép gan, nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim thường giảm (Có thể là do bệnh nhân ngưng dùng steroid). Tỷ lệ ở bệnh nhân hút thuốc lá là 20,3%, cao huyết áp 49,1%, béo phì 22,4%, tăng cholesterol 34,5%, tăng triglycerid 11,2% và tăng homocystein máu 57,8%. Bệnh nhân được dùng tacrolimus hoặc cyclosporin sau ghép, nhưng cyclosporin liên quan với tăng cholesterol, huyết áp, homocystein. Do vậy ở bệnh nhân ghép gan, bác sĩ không phải lo lắng nhiều về biến chứng tim mạch do dùng thuốc chống thải ghép.

BS. NGỌC LAN

(Theo *NEJM*, 03/2003)

□ GIẢM LƯỢNG NƯỚC ỒI KHÔNG CÒN ĐANG LO NGẠI

Trước nay, các nhà sản khoa đều lo ngại về tình trạng giảm số lượng nước ối ở phụ nữ có thai những tháng cuối. Nước ối giảm sẽ gây sinh khó, có thể làm quần dây rốn, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. Người ta xếp những phụ nữ bị giảm nước ối giai đoạn cuối thai kỳ vào nhóm có nguy cơ cao và theo dõi để khi cần có thể can thiệp (sinh chỉ huy hoặc mổ bắt con). Các nhà khoa học Mỹ qua nghiên cứu 262 sản phụ có tuổi thai trên 26 tuần, được chẩn đoán là giảm nước ối trong vòng 7 ngày trước sinh (xác định có 1/2 sản phụ bị bệnh thiếu ối và 1/2 bình thường). Sản phụ bị giảm nước ối tuy được sinh sớm hơn nhưng ít phải mổ và trẻ sinh ra cũng ít bị bệnh hoặc bất thường về kích thước. Trẻ sơ sinh gần đủ tháng thiếu ối không hề yếu hơn những trẻ khác, do đó có thể để sản phụ chuyển dạ bình thường mà không cần can thiệp sớm. Người ta cho rằng việc xét nghiệm chính nước ối sẽ tiên lượng được tình trạng sức khỏe của thai nhi, còn việc đo thể tích nước ối là không cần thiết.

(Theo *Contraception*, 03/2003)

□ PHÁT HIỆN VỀ TÁC DỤNG CHỐNG NHÂN DA CỦA KEM TRỊ MỤN

Tazaroten là một dạng retinoid (dẫn xuất của vitamin A) có tác dụng thúc đẩy sự tăng sinh của collagen da, làm giảm nếp nhăn da. Có nhiều retinoid đang được sử dụng và trong đó một số không cần kê đơn. Hiện nay tazaroten được chỉ định để điều trị mụn trứng cá và bệnh vẩy nến.



dùng placebo.

Sau 24 tuần, tất cả những người dùng tazaroten một ngày/lần được dùng thêm 28 tuần và đa của họ đã cải thiện hơn. Tuy nhiên bệnh nhân cần lưu ý đến việc tránh nắng và đeo kính râm hơn là quả dưa vào sản

Tác dụng phụ thường gặp của tazaroten là làm đỏ da, khô da, lột da... Tuy nhiên, những triệu chứng này sẽ giảm dần và biến mất khi da đã quen với thuốc. Qua một nghiên cứu mù đôi có kiểm chứng trên 563 bệnh nhân dùng kem tazaroten hoặc placebo trong 24 tuần đầu tham gia, sau đó tất cả đều được dùng tazaroten cho đến hết năm. Kết quả cho thấy những người dùng kem tazaroten trong 24 tuần giảm được nhân da và nứt da tổn thương do ánh nắng mặt trời nhiều hơn so với người

phẩm bảo vệ da vừa nêu.

(Theo *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 03/2003)

BS. ĐĂNG MINH TRÍ

□ CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ VIRAMUNE® PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỰ MẸ SANG CON TẠI VIỆT NAM

Ngày 6/11/2002, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á tham gia vào Chương trình viện trợ VIRAMUNE® của tập đoàn Boehringer Ingelheim (CHLB Đức). Theo cam kết trong chương trình, Boehringer Ingelheim sẽ cung cấp miễn phí thuốc VIRAMUNE® (Nevirapine) cho Việt Nam trong 5 năm để dùng vào việc ngăn chặn sự lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con.

Theo dữ liệu giám sát quốc gia 2002, tần suất phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV được dự đoán là 0,34%, nhưng tại một số tỉnh thành ở nước ta như Quảng Ninh, Hải Phòng, An Giang, TPHCM, Hà Nội... số phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV tăng nhanh lên đến 0,5% hoặc 0,9%. Ngoài các đối tượng sử dụng ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi, hiện HIV đang có chiều hướng lan nhanh đến các thành phần khác, bao gồm những phụ nữ trong thời kỳ mang thai (nguồn UNAIDS - 2002).

Được biết hiện tập đoàn Boehringer Ingelheim đang cung cấp thuốc cho 70 chương trình của 41 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, châu Á, Đông Âu và được các quốc gia đang phát triển rất quan tâm.

P.V

Hãy giảm cân, đừng giảm tuổi thọ

Khi quyết định giảm bớt trọng lượng của cơ thể, bạn sẽ lạc vào giữa một rừng các sản phẩm giảm cân. Nhưng một lựa chọn sai lầm có thể gây cho bạn những nguy hiểm chết người, đó là những sản phẩm giảm béo hoàn toàn phụ thuộc vào thành phần giảm phẩm gây chán ăn như: fenfluramine, dextfenfluramin và phentermine. Nguy hiểm hơn, những sản phẩm này có thể gây ra những phản ứng phụ khó lường như: bệnh huyết áp, bệnh tim do van tim và bệnh gan. Trên thực tế đã có nhiều tai nạn đáng tiếc do thuốc giảm béo gây ra.

Là một công ty dược phẩm có uy tín và trách nhiệm, chủ trương của chúng tôi là không bao giờ mạo hiểm với sức khỏe và tính mạng của khách hàng. Đó là lý do tại sao chương trình 7 ngày tuyệt hảo của Appeton Fat Loss (AFL) ra đời, như một trong những cách giảm cân an toàn nhất. AFL là thực phẩm ăn kiêng ít calo (VLDC) nghiêm ngặt tuân theo "Tiêu chuẩn dinh dưỡng hàng ngày Hoa Kỳ" (USRDA). AFL cung cấp cho

bạn tất cả carbohydrat, protein, Omega-3 và dưỡng chất cần thiết để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. AFL không chứa bất cứ thành phần nào có hại cho bạn. Ngược lại, AFL còn giúp bạn bảo vệ cơ bắp không bị mất đi, một phản ứng phụ thường gặp khi ăn kiêng. Đó là nhờ "Mô chuỗi trung bình" (MCT), một thành phần tự nhiên giúp cơ thể bạn bảo vệ cơ bắp và đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

Nhờ MCT, tỷ lệ trao đổi chất sẽ tăng đáng kể và duy trì ở mức tối ưu, ngăn ngừa tăng cân ngay cả khi bạn đã chấm dứt chế độ ăn kiêng.

Ngày bây giờ, hãy bắt đầu thay thế bữa ăn hàng ngày của bạn bằng thức uống hoặc súp đủ dinh dưỡng của AFL. Chỉ trong 7 ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả thật sự của nó.



Chương trình giảm cân 7 ngày tuyệt hảo
Sản phẩm của Hà Lan

APPETON

www.appeton.com



Công ty TNHH Mỹ Phẩm 2Kway
33/18B-Cụm Khu phố 7, Tân Định, Q.1, TP.HCM - ĐT: (84) 8433362 - (84) 8481096 - Fax: (84) 8480287
17/179 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (84) 5371819 - (84) 5372889 - Fax: (84) 5371828

HỎI ĐÁP VỀ SỨC KHỎE

◆ NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP KHÁNG SINH

Hỏi: Gia đình tôi có 2 lần đưa người thân vào khám tại bệnh viện. Sau khi khám xong bác sĩ kê đơn như sau:

Đơn thứ nhất: Họ và tên người bệnh: Trần Thị D., tuổi 47..., căn bệnh: viêm xoang.

1. Cefa 0,5g x 15 viên (ngày uống 3 viên chia 3 lần).

2. Cotrim 960mg x 10 viên (ngày uống 3 viên chia 3 lần).

3. Paradol 500mg x 15 viên. Ngày 3 viên chia 3 lần.

4. Bcomlex x 15 viên. Ngày uống 3 viên chia 3 lần.

Đơn thứ 2: Họ tên người bệnh: Cao Thị C. Tuổi 51.... Căn bệnh: viêm cơ.

1. Amox 0,5g x 20 viên (ngày uống 2 lần, lần 2 viên).

2. Cotrim 960mg x 15 viên (ngày uống 3 lần, lần 1 viên).

3. Bcomlex x 15 viên (ngày uống 3 lần, lần 1 viên).

Vậy nguyên tắc phối hợp kháng sinh của 2 đơn trên đúng hay sai? Nhờ bác sĩ giải thích thêm để chúng tôi có thể yên tâm điều trị bệnh khi gặp một đơn thuốc tương tự.

(Đ.T.L. - Cần Thơ)

Trả lời: Trong sử dụng kháng sinh, có khi ta phải phối hợp dùng 2 hoặc nhiều kháng sinh cùng lúc để đạt hiệu quả trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn. Có thể kể một số trường hợp cần phải phối hợp kháng sinh như: Nhiễm nhiều loại vi khuẩn, nhiễm khuẩn giảm bạch cầu, sốc nhiễm khuẩn, bệnh lao, bệnh viêm màng trong tim v.v... Đúng như bạn nêu trong thư, có một số nguyên tắc cần tuân thủ khi phối hợp 2 kháng sinh trở lên như:

Hai kháng sinh phối hợp không cùng một họ, tức là chúng phải khác nhóm (Penicillin không được phối hợp với một kháng sinh thuộc

nhóm Penicillin mà nên phối hợp với một kháng sinh thuộc nhóm Aminocyclitol).

Hai kháng sinh phối hợp nên cùng loại tác dụng, hoặc cùng tác dụng hãm khuẩn (còn được gọi là *kiềm khuẩn, trụ khuẩn*, tức chỉ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, trong thư bạn gửi, "ngưng trùng" cũng để chỉ tác dụng này) hoặc cùng tác dụng diệt khuẩn (tức tiêu diệt được vi khuẩn, trong thư bạn gửi là "diệt trùng").

Hai kháng sinh phối hợp không gây độc trên cùng một cơ quan, thí dụ như không phối hợp hai kháng sinh cùng nhóm Aminocyclitol (ví nhóm Aminocyclitol gây độc cho tai và thận, làm điếc và suy thần kinh trong nếu phối hợp).

Hai kháng sinh phối hợp không cho dễ kháng chéo, thí dụ không nên phối hợp Cefoxitin với Penicillin vì Cefoxitin kích thích vi khuẩn tiết ra enzym để kháng với Penicillin. Thắc mắc của bạn nêu trong thư liên quan đến đơn thuốc có sự phối hợp kháng sinh hãm khuẩn với kháng sinh diệt khuẩn, trái với nguyên tắc nêu trên. Xin được trả lời như sau:

- Một kháng sinh có khi hãm khuẩn có khi diệt khuẩn tùy thuộc vào điều kiện mà nó cho tác dụng. Thí dụ Erythromycin được xem là kháng sinh hãm khuẩn nhưng có khi lại diệt khuẩn tùy thuộc vào vi khuẩn mà nó tác dụng và vào nồng độ thuốc có trong máu (nhiều kháng sinh khác cũng thế, nồng độ thuốc trong máu thấp có tính hãm khuẩn nhưng nếu cao sẽ có tính diệt khuẩn).

- Cotrim (Viết tắt của Cotrimoxazol với tên biệt dược là Bactrim) là thuốc phối hợp sẵn hai kháng sinh: một là Sulfamethoxazol (một Sulfamid có tính hãm khuẩn), hai là Trimethoprim có tính hãm khuẩn. Tuy nhiên, khi phối hợp như thế, Cotrimoxazol không có tính hãm khuẩn mà có tác dụng mạnh hơn là diệt khuẩn.

- Cotrimoxazol là thuốc đã có sự phối hợp sẵn hai kháng sinh đã được tác dụng diệt khuẩn. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần dùng một

minh thuốc này cũng đủ để trị bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp có sự kết hợp Cotrimoxazol với một kháng sinh khác, như Cotrimoxazol kết hợp với Erythromycin (có biệt dược phối hợp sẵn như Erybactrim, Sulferycin).

Trong hai đơn thuốc mà bạn nêu trong thư, sự phối hợp cefa (tức Cefalexin, kháng sinh diệt khuẩn) với Cotrim (kháng sinh diệt khuẩn), hoặc amox (tức Amoxycillin, kháng sinh diệt khuẩn) với Cotrim là đúng về mặt nguyên tắc phối hợp kháng sinh. Tức hai kháng sinh phối hợp đều cùng loại diệt khuẩn. Với kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ điều trị đã dùng phác đồ phối hợp kháng sinh như thế để xử lý tốt ổ nhiễm khuẩn.

TS. DS. NGUYỄN HỮU ĐỨC

◆ NỐT RUỐI NÀO CÓ THỂ PHÁT TRIỂN THÀNH UNG THƯ?

Hỏi: Em có một nốt ruồi ở cánh mũi, gần đây phát triển lớn dần và ngứa. Xin bác sĩ cho biết có cách nào làm cho nốt ruồi chậm phát triển, cắt bỏ có được không và nên dùng cơ sở nào để đảm bảo an toàn?

(Điều Hiền - Cà Mau)

Trả lời: Nốt ruồi là do sự tập trung nhiều tế bào sắc tố Melanin ở một hoặc nhiều vùng trên cơ thể. Về cơ chế bệnh sinh cũng như vị trí, số lượng nốt ruồi, hiện người ta vẫn chưa lý giải được. Có nhiều loại nốt ruồi khác nhau như:

- Nốt ruồi ở thượng bì - hạ bì.
- Nốt ruồi màu xanh.
- Nốt ruồi có lông - không có lông.
- Nốt ruồi son (u mạch máu).

Hầu hết các nốt ruồi là lành tính, nhất là nốt ruồi có lông (99,9% là lành tính). Tuy nhiên các nốt ruồi ở những vị trí dễ bị kích thích, chịu tác động lặp đi lặp lại nhiều lần như sờ nắn, nặn, phơi nắng nhiều có thể sẽ trở thành ác tính (ung thư da). Cũng nên cảnh giác với các nốt ruồi đột nhiên lớn nhanh, đau, ngứa, dễ chảy máu khi chạm tới, những nốt ruồi ở các vị trí như cơ quan sinh dục, vú, thất lưng, mặt mũi... Tuy nhiên cũng cần phân biệt

với sang thương có màu đen thường ở trên trán - trên mắt - mắt hoặc vùng da khác, lúc còn nhỏ rất giống nốt ruồi nhưng thực chất là dạng ung thư tế bào đáy của da, thường gặp ở người cao tuổi.

Hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào cho thấy có thể làm chậm lại sự phát triển của nốt ruồi, chỉ có biện pháp duy nhất là để yên, tránh kích thích chúng khi chưa có điều kiện điều trị. Nốt ruồi của em có các biểu hiện như ngứa, lớn dần, đó là dấu hiệu nguy cơ cao, hơn nữa ở vị trí rất dễ bị tác động bởi các kích thích như ánh nắng mặt trời, lau rửa mặt hàng ngày... Vì vậy em cần loại bỏ nốt ruồi trên càng sớm càng tốt. Em có thể đến trạm da liễu địa phương, Bệnh viện Da liễu Thành phố hay Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Bưu Điện II để điều trị.

BS. CKI. TRẦN QUỐC LONG

◆ TINH DỤC KHI CÓ THAI

Hỏi: Thời gian gần đây, báo SK&DS đã nhận được khá nhiều thư bạn đọc thắc mắc về vấn đề tinh dục và thai nghén. Nay chúng tôi tập hợp lại và trả lời một số nội dung cơ bản liên quan đến lĩnh vực này.

Trả lời: Trước nay do có nhiều lời đồn đại chưa đúng hoặc coi quan hệ tình dục là điều cấm kỵ nên thấy thuốc cũng ít khi khuyên người phụ

nữ có thai chấp nhận chuyện quan hệ tình dục như thế nào? Thật ra chỉ cần thận trọng và có một số hiểu biết nhất định.

Khi có thai có quan hệ tình dục được không? Trong phần lớn trường hợp câu trả lời là được (nếu thai kỳ đang diễn ra bình thường và thấy thuốc không cảnh báo về nguy cơ dễ bị sinh non). Một số trường hợp cổ tử cung mở non (hở cổ tử cung) hoặc nhau bám bất thường vẫn có thể quan hệ tình dục được cho tới quý 3 của thai nghén, nhưng nhiều thấy thuốc khuyên cần thận trọng.

Quan hệ tình dục có gây sảy thai? Nhiều thai phụ lo bị sảy thai vào 3 tháng đầu nhưng sảy thai thường không liên quan đến chuyện tình dục mà nguyên nhân phổ biến nhất là do có khuyết tật về gen ở thai. Nhiễm khuẩn cũng là yếu tố gây sảy thai nhưng không phải do quan hệ tình dục; Nhiều thấy thuốc vẫn khuyên nên tránh quan hệ tình dục quá mạnh mẽ trong 3 tháng đầu và chọn tư thế thích hợp trong những tháng sau.

Quan hệ tình dục có hại đến thai nhi không? Không. Không có sự tiếp xúc nào với thai nhi, kể cả tình dịch. Nút niêm dịch cổ tử cung ngăn không cho vi khuẩn và tinh dịch vào tử cung. Tuy nhiên, nên tránh quan hệ quá mạnh bạo.

Khoái cực có gây ra sinh non?

Khoái cực có thể gây cơ co tử cung, tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy với thai nghén bình thường không dẫn đến chuyển dạ sớm hoặc sinh non.

Những trường hợp không thể quan hệ tình dục khi mang thai? Ra máu âm đạo, hở cổ tử cung, chuyển dạ sớm, nhau tiền đạo (nhau che phủ lỗ trong cổ tử cung) thường được khuyên không nên quan hệ tình dục. Nên kiêng quan hệ tình dục vào cuối quý 2 và đầu quý 3 khi nguy cơ sinh non dễ xảy ra nhất. Vì thận trọng nên cũng cần kiêng vào tuần cuối của thai kỳ.

Có cần dùng bao cao su không? Mọi phụ nữ, kể cả những phụ nữ có thai, nếu có bạn tình mới hoặc nhiều bạn tình đều cần dùng bao cao su để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phụ nữ có thai nếu bị phơi nhiễm với bệnh lây truyền qua đường tình dục thì có nguy cơ cao nhiễm bệnh, có thể nguy hại cho thai và dẫn đến sinh non.

Ham muốn tình dục có giảm khi có thai không? Những thay đổi về hormone, tăng cân và giảm năng lượng chung của cơ thể có thể làm giảm đáng kể sự quan tâm đến tình dục vào giai đoạn đầu mới có thai, cũng như có thể kéo dài suốt quý 1 khi những triệu chứng khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn dễ xảy ra nhất. Nhưng đến 3 tháng giữa thì cơ thể thay đổi, ham muốn trở lại thậm chí tăng hơn bình thường do lưu lượng máu tới cơ quan sinh dục và vú tăng lên. Đến 3 tháng cuối, ham muốn lại giảm đi do lúc này bụng đã quá to cồng với tình trạng mệt mỏi hoặc đau lưng nên gây khó khăn cho quan hệ tình dục. Nhiều người đã thử thay đổi bằng những tư thế thích hợp và một số phụ nữ có thai thích được quan tâm chăm sóc hơn là muốn quan hệ tình dục.

Sau sinh bao lâu, có thể quan hệ tình dục? Còn tùy từng hoàn cảnh, nói chung có thể quan hệ tình dục trở lại vào tuần thứ ba sau sinh nếu thấy khỏe khoắn và không có yếu tố nguy cơ gì. Cũng có thấy thuốc khuyên sau 6 tuần... Nói chung, các cặp vợ chồng thường quan hệ tình dục trở lại 7-8 tuần sau sinh.

BS. ĐÀO XUÂN DUNG

MỜI ĐẶT MUA BẢO SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG CUỐI TUẦN

Kính mời quý độc giả đặt mua báo **Sức Khỏe & Đời Sống cuối tuần** phát hành thứ sáu hàng tuần, năm 2003 với 32 trang nội dung hấp dẫn, thiết thực bổ ích...

Trình bày đẹp, trang nhã. Giá không thay đổi (4.000đ/cuốn).

Quý I : 13 kỳ x 4.000đ = 52.000đ

(Số 212 + 213 + 214 xuân Quý Mùi).

Quý II : 13 kỳ x 4.000đ = 52.000đ

Quý III : 13 kỳ x 4.000đ = 52.000đ

Quý IV : 13 kỳ x 4.000đ = 52.000đ

Tổng cộng: 208.000đ

Quý độc giả có thể đặt mua từng tháng, quý hay cả năm 2003 tại các bưu cục gần nhà trong cả nước hoặc: 213 Điện Biên Phủ - Q.3 - TPHCM, ĐT: 8229942, Fax: (84.8) 8237593.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý độc giả.